Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 1

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 1

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 1

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition : concepts, modes d'intervention, acteurs et politiques nutritionnelles

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 1

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Santé publique; Promotion de la santé; Politiques nutritionnelles

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 1 : concepts de santé, santé publique, danger et risque, modes d'intervention, acteurs, politiques de santé et politiques nutritionnelles, place du diététicien (référentiel du 27 novembre 2024, savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas (concepts de santé, « Une seule santé », missions, niveaux de prévention, Charte d'Ottawa, acteurs, projet régional de santé, frise des politiques nutritionnelles, démarche de projet) ; Calculer et interpréter des indicateurs simples (pourcentages, écarts, rapports, nombres de cas évités) et les relier à une décision d'action ; Qualifier une action de santé publique et l'inscrire dans les politiques en vigueur en octobre 2026.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 1.1 – Légender l'évolution des concepts de santé (10 points) ; Exercice 1.2 – Reconnaître un modèle de santé dans un discours (10 points) ; Exercice 1.3 – Discuter la définition de l'OMS (10 points) ; Exercice 1.4 – Interpréter un indicateur de santé perçue (12 points) ; Exercice 1.5 – « Une seule santé » appliquée à la restauration scolaire (12 points) ; Exercice 1.6 – Rédiger l'introduction d'un dossier E5 (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 2.1 – Légender les missions de la santé publique (9 points) ; Exercice 2.2 – Approche clinique ou approche de santé publique ? (10 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Public health and health promotion in nutrition: concepts, modes of intervention, stakeholders and nutrition policies. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 1 : concepts de santé, santé publique, danger et risque, modes d'intervention, acteurs, politiques de santé et politiques nutritionnelles, place du

■ Légender des schémas (concepts de santé, « Une seule santé », missions, niveaux de prévention, Charte d'Ottawa, acteurs, projet régional de santé, frise des politiques nutritionnelles, démarche de projet).

■ Calculer et interpréter des indicateurs simples (pourcentages, écarts, rapports, nombres de cas évités) et les relier à une décision d'action.

■ Qualifier une action de santé publique et l'inscrire dans les politiques en vigueur en octobre 2026.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 1 5
Mode d'emploi du cahier 5
Partie 1 – Les concepts de santé 6
Exercice 1.1 – Légender l'évolution des concepts de santé (10 points) 7
Exercice 1.2 – Reconnaître un modèle de santé dans un discours (10 points) 8
Exercice 1.3 – Discuter la définition de l'OMS (10 points) 9
Exercice 1.4 – Interpréter un indicateur de santé perçue (12 points) 10
Exercice 1.5 – « Une seule santé » appliquée à la restauration scolaire (12 points) 11
Exercice 1.6 – Rédiger l'introduction d'un dossier E5 (16 points) 13
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 16
Exercice 2.1 – Légender les missions de la santé publique (9 points) 17
Exercice 2.2 – Approche clinique ou approche de santé publique ? (10 points) 18
Exercice 2.3 – Calculer le paradoxe de la prévention (14 points) 19
Exercice 2.4 – Distinguer incidence et prévalence (10 points) 21
Exercice 2.5 – Les missions de la santé publique face à une toxi-infection alimentaire collective (12 points) 22
Exercice 2.6 – Convaincre des élus d'une action populationnelle (16 points) 23
Corrigés de la partie 2 24
Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection 26
Exercice 3.1 – Légender la chaîne du risque (12 points) 27
Exercice 3.2 – Classer les notions (10 points) 28
Exercice 3.3 – Calculer et interpréter un risque (12 points) 29
Exercice 3.4 – La listériose chez la femme enceinte (12 points) 30
Exercice 3.5 – Facteurs de risque et facteurs de protection dans un quartier (12 points) 31
Exercice 3.6 – Hiérarchiser des problèmes de santé (16 points) 32
Corrigés de la partie 3 33
Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique 35
Exercice 4.1 – Légender les niveaux de prévention (12 points) 36
Exercice 4.2 – Les 5 domaines et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa (14 points) 37
Exercice 4.3 – Qualifier une action (12 points) 39
Exercice 4.4 – Appliquer l'universalisme proportionné à la cantine (14 points) 40
Exercice 4.5 – Choisir une approche éducative (12 points) 41
Exercice 4.6 – Construire une réponse combinant les quatre modes (16 points) 42
Corrigés de la partie 4 43
Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 45
Exercice 5.1 – Légender la carte des acteurs (10 points) 46
Exercice 5.2 – Qui fait quoi ? (10 points) 47
Exercice 5.3 – Trouver la bonne source de données (12 points) 48
Exercice 5.4 – Construire un plan de financement (12 points) 49
Exercice 5.5 – Repérer un conflit d'intérêts (12 points) 50
Exercice 5.6 – Construire la carte des partenaires d'un projet (16 points) 51
Corrigés de la partie 5 52
Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale 54
Exercice 6.1 – Légender l'architecture de la politique régionale de santé (10 points) 55
Exercice 6.2 – Reconnaître les outils d'une politique publique (10 points) 56
Exercice 6.3 – Les étapes d'une politique publique : l'exemple du PNNS 5 (12 points) 57
Exercice 6.4 – Analyser une fiche-action de contrat local de santé (12 points) 58
Exercice 6.5 – Relier une action locale aux politiques (12 points) 59
Exercice 6.6 – Répondre à un appel à projets de l'ARS (16 points) 60
Corrigés de la partie 6 61
Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique 63

Exercice 7.1 – Légender la frise des politiques nutritionnelles (8 points) 64
Exercice 7.2 – Présenter le PNNS 5 et la SNANC (12 points) 65
Exercice 7.3 – Calculer les taux EGalim d'une cantine (12 points) 66
Exercice 7.4 – Utiliser les repères alimentaires (12 points) 67
Exercice 7.5 – Le Nutri-Score (12 points) 68
Exercice 7.6 – Argumenter une diversification des protéines (16 points) 69
Corrigés de la partie 7 70

Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet 72
Exercice 8.1 – Légender la démarche de projet (10 points) 73
Exercice 8.2 – Le cadre réglementaire de la profession (10 points) 74
Exercice 8.3 – Posture et déontologie en situation (12 points) 75
Exercice 8.4 – Rédiger des objectifs mesurables (12 points) 76
Exercice 8.5 – Classer les besoins selon Bradshaw (10 points) 77
Exercice 8.6 – Cas de synthèse : la santé alimentaire des étudiants d'un campus (30 points) 78
Corrigés de la partie 8 79

Bilan : grille d'auto-évaluation 81

Cahier d'exercices – Chapitre 1

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 1 : concepts de santé, santé publique, danger et risque, modes d'intervention, acteurs, politiques de santé et politiques nutritionnelles, place du diététicien (référentiel du 27 novembre 2024, savoirs associés « Enjeux de santé publique » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas (concepts de santé, « Une seule santé », missions, niveaux de prévention, Charte d'Ottawa, acteurs, projet régional de santé, frise des politiques nutritionnelles, démarche de projet).
- Calculer et interpréter des indicateurs simples (pourcentages, écarts, rapports, nombres de cas évités) et les relier à une décision d'action.
- Qualifier une action de santé publique et l'inscrire dans les politiques en vigueur en octobre 2026.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de textes), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes et chiffres locaux des mises en situation sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les données nationales, les textes et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026.

Partie 1 – Les concepts de santé

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la santé selon l'OMS (1946), en citer les apports et les limites.
- Distinguer modèle biomédical, modèle biopsychosocial, santé comme ressource (Charte d'Ottawa) et approche « Une seule santé ».
- Distinguer santé objective, santé perçue et santé positive ; interpréter un indicateur de santé perçue.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Constitution signée le 22 juillet 1946, en vigueur le 7 avril 1948.
- Modèle biopsychosocial : George Engel, 1977. Charte d'Ottawa (1986) : la santé est « une ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie ».
- Santé comme capacité d'adaptation : Machteld Huber et coll., BMJ, 2011.
- « Une seule santé » (One Health) : principes de Manhattan (2004) ; définition du panel OHHLEP (2021) adoptée par la Quadripartite (OMS, FAO, OMSA, PNUE) ; plan d'action conjoint 2022-2026.
- Santé perçue : déclarée par la personne ; elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux.

Exercice 1.1 – Légender l'évolution des concepts de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez l'introduction de votre dossier E5 et vous voulez montrer au jury que votre projet s'appuie sur une conception actuelle de la santé.

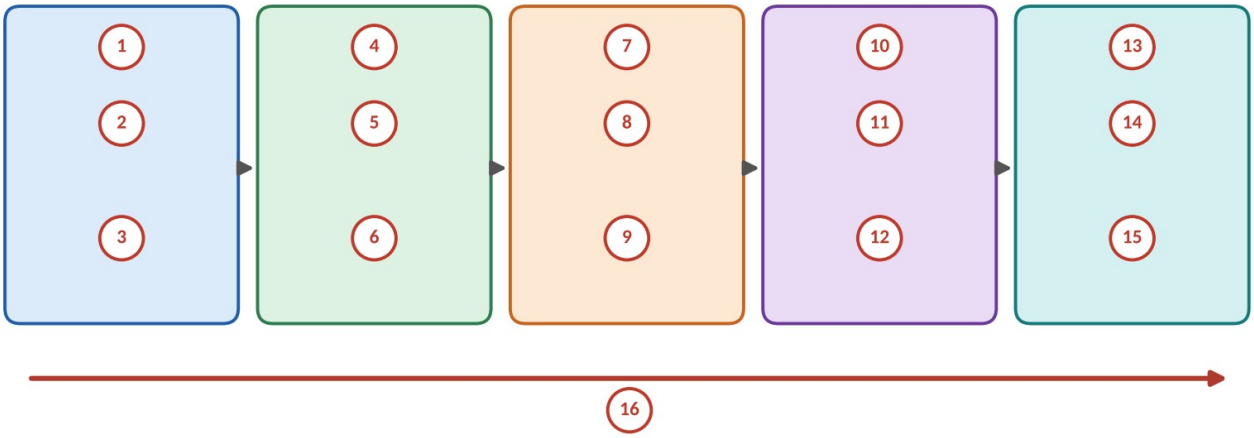


Figure 1.1 – Document 1 – L'évolution des concepts de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 16 du document 1 (nom du modèle, date ou auteur, idée principale). (6 pts)

2. Expliquez le sens de la flèche rouge placée sous le schéma. (2 pts)

3. Indiquez quel modèle justifie qu'un diététicien agisse sur les menus d'une cantine plutôt que seulement en consultation. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 1.2 – Reconnaître un modèle de santé dans un discours (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de préparation d'un forum santé dans une commune, vous notez les phrases prononcées par les participants.

Document 1 – Phrases entendues pendant la réunion

a) Le médecin : « Les habitants dont la glycémie est normale sont en bonne santé, on n'a pas besoin de s'occuper d'eux. »

b) L'adjointe aux affaires sociales : « Sans logement correct et sans revenu, on ne peut pas parler de santé. »

c) Une habitante qui a un diabète de type 1 depuis 20 ans : « Je cours des semi-marathons, je travaille, je me sens bien : je suis en bonne santé. »

d) Le responsable de la restauration scolaire : « En servant moins de viande et plus de légumineuses, on agit pour les enfants, pour les élevages et pour le climat. »

e) La psychologue du centre médico-psychologique : « Le stress au travail et l'isolement expliquent une partie des grignotages que nous voyons. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque phrase à un modèle ou à un concept de santé ; justifiez en une phrase. (5 × 1,5 pt)

2. Montrez, à partir de la phrase c, une limite de la définition de l'OMS. (2,5 pts)

Ma réponse

Exercice 1.3 – Discuter la définition de l'OMS (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Madame L., 34 ans, a une maladie cœliaque diagnostiquée il y a 8 ans. Elle suit un régime strict sans gluten, ses anticorps sont négatifs, elle travaille à temps plein et anime une association de patients. Elle vous dit : « Selon la définition officielle, je ne serai jamais en bonne santé, puisque je suis malade à vie. »

Document 1 – Deux définitions

Définition de l'OMS (1946) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

Proposition de M. Huber et coll. (BMJ, 2011) : la santé comme « capacité à s'adapter et à se prendre en charge face aux défis sociaux, physiques et émotionnels ».

À vous de jouer – Questions

1. Citez les trois apports de la définition de l'OMS qui l'ont rendue novatrice en 1946. (3 pts)

2. Présentez trois critiques de cette définition. (3 pts)

3. Montrez que la proposition de Huber permet de considérer que Madame L. est en bonne santé. (2 pts)

4. Indiquez ce que cette réflexion change dans la façon d'animer un atelier pour des personnes atteintes d'une maladie chronique. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 1.4 – Interpréter un indicateur de santé perçue (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire de la santé d'une agglomération (données fictives) a interrogé 2 800 adultes, répartis en quatre groupes égaux de revenus (quartiles). Vous devez présenter ces résultats au comité de pilotage d'un projet « Alimentation et santé » de l'agglomération.

Document 1 – Adultes se déclarant en bonne ou très bonne santé, selon le revenu (enquête fictive, 2025)

Quartile de revenu	Effectif interrogé	Adultes se déclarant en bonne ou très bonne santé
Quartile 1 (25 % les plus modestes)	700	412
Quartile 2	700	498
Quartile 3	700	553
Quartile 4 (25 % les plus aisés)	700	602

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la santé perçue et indiquez pourquoi c'est un indicateur utile en santé publique. (2 pts)

2. Calculez, pour chaque quartile, la part des adultes en bonne ou très bonne santé. (4 pts)

3. Calculez l'écart absolu (en points) et le rapport entre le quartile 4 et le quartile 1 ; interprétez. (3 pts)

4. Nommez le phénomène mis en évidence et indiquez une conséquence pour la conception du projet. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 1.5 – « Une seule santé » appliquée à la restauration scolaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage auprès du service de restauration d'une commune de 18 000 habitants (structure fictive). Les élus veulent présenter au conseil municipal le passage à deux repas végétariens par semaine dans les écoles et l'achat de volailles élevées sans antibiotiques. Ils vous demandent un schéma et un argumentaire « Une seule santé ».

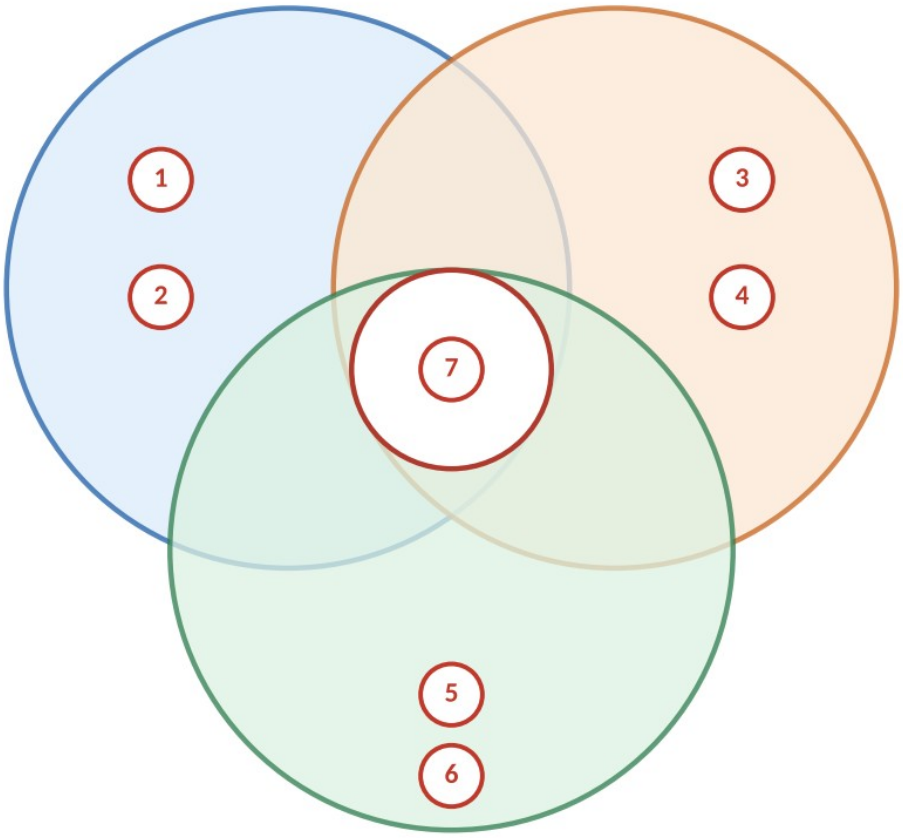


Figure 1.2 – Document 1 – « Une seule santé » (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (3,5 pts)
2. Donnez la définition de l'approche « Une seule santé » et citez les quatre organisations de la Quadripartite. (2,5 pts)
3. Montrez, pour chacune des deux mesures, ses effets attendus sur les trois santés. (4 pts)
4. Indiquez deux points de vigilance nutritionnelle qui relèvent du diététicien pour les repas végétariens des enfants. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 1.6 – Rédiger l'introduction d'un dossier E5 (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans un centre social qui accueille des familles d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (structure fictive). Votre projet porte sur un « café des parents » consacré à l'alimentation des enfants de 3 à 6 ans. Votre tutrice vous demande de rédiger l'introduction du dossier, d'une demi-page, en montrant au lecteur que l'action ne se limite pas à « donner des conseils ».

Document 1 – Notes prises pendant l'observation

- 28 familles inscrites au centre social ont un enfant de 3 à 6 ans ; 11 familles vivent dans un logement sans four.
- Les parents disent manquer de temps et d'argent ; certains se sentent jugés par l'école sur le contenu du goûter.
- Le marché du quartier a lieu le samedi ; la supérette la plus proche vend peu de fruits et légumes frais.
- Les parents demandent des idées de goûters « que les enfants aiment et qui ne coûtent pas cher ».

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez, dans le document 1, les éléments qui relèvent de chacune des trois dimensions du modèle biopsychosocial. (4,5 pts)
2. Montrez que la situation illustre la santé comme « ressource de la vie quotidienne » au sens de la Charte d'Ottawa. (3 pts)
3. Rédigez l'introduction du dossier (une demi-page) : définition de la santé retenue, justification de l'approche, annonce du projet. (6 pts)
4. Relevez une phrase du document 1 qui doit vous alerter sur le risque de stigmatisation et indiquez comment vous en tenez compte. (2,5 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 1.1

1. Légendes : 1 Modèle biomédical ; 2 XIXe siècle – milieu du XXe ; 3 Santé = absence de maladie, action curative et individuelle ; 4 Définition de l'OMS ; 5 1946 (en vigueur en 1948) ; 6 Bien-être physique, mental et social, droit fondamental ; 7 Modèle biopsychosocial ; 8 Engel, 1977 ; 9 Interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux ; 10 Charte d'Ottawa ; 11 1986 ; 12 Santé = ressource de la vie quotidienne, promotion de la santé ; 13 Une seule santé ; 14 Principes de Manhattan, 2004 ; 15 Santé humaine, animale et des écosystèmes liées ; 16 De l'individu malade à la population, puis à la planète.

2. La flèche montre l'élargissement du regard : on passe d'une santé définie chez l'individu malade (soigner) à une santé de la population, dépendant de ses conditions de vie (prévenir, promouvoir), puis à une santé liée à celle des animaux et des écosystèmes (alimentation durable).

3. Le modèle biopsychosocial et la Charte d'Ottawa : la santé dépend des conditions de vie et des milieux (ici le milieu scolaire). Agir sur les menus, c'est « créer des milieux favorables », un des cinq domaines d'action de la Charte.

Corrigé – Exercice 1.2

1. a) Modèle biomédical : la santé est réduite à un résultat biologique normal ; on ignore le vécu et les déterminants. b) Charte d'Ottawa : le logement et le revenu font partie des conditions préalables à la santé (paix, abri, éducation, nourriture, revenu, écosystème stable, ressources durables, justice sociale et équité). c) Santé comme capacité d'adaptation (Huber, 2011) et santé perçue : malgré une maladie chronique, la personne fonctionne et se sent bien. d) « Une seule santé » : la mesure agit sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement. e) Modèle biopsychosocial : des facteurs psychologiques (stress) et sociaux (isolement) expliquent un comportement alimentaire.

2. Selon l'OMS, la santé est un état de « complet » bien-être : une personne qui a une maladie chronique ne pourrait jamais être en bonne santé. Or l'habitante de la phrase c mène une vie pleinement satisfaisante. La définition décrit un idéal figé et ne tient pas compte de la capacité d'adaptation.

Corrigé – Exercice 1.3

1. Apports : définition positive (le bien-être et pas seulement l'absence de maladie) ; multidimensionnelle (physique, mentale, sociale) ; la santé est un droit fondamental de tout être humain.

2. Critiques : le « complet » bien-être est un idéal presque inatteignable ; c'est un état figé alors que la santé est un équilibre dynamique ; la définition ne dit rien de la capacité d'adaptation et exclut les personnes qui vivent bien avec une maladie chronique ; elle est difficile à mesurer.

3. Madame L. s'adapte à sa maladie : elle suit son régime, ses anticorps sont négatifs, elle travaille et s'engage dans une association. Selon Huber, elle a la capacité de faire face aux défis physiques, sociaux et émotionnels : elle est en bonne santé, même si elle a une maladie chronique.

4. L'atelier part des ressources et des compétences des participants, et pas seulement de leurs « problèmes » ; il valorise ce qu'ils savent déjà faire, cherche à renforcer leur autonomie (pouvoir d'agir) et évite un discours centré sur la maladie et les interdits.

Corrigé – Exercice 1.4

1. La santé perçue est l'état de santé déclaré par la personne elle-même (« Comment jugez-vous votre état de santé ? »). Elle est simple à recueillir, comparable entre groupes et dans le temps, et elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux. Elle est utilisée dans le Baromètre de Santé publique France et l'enquête européenne EHIS.

2. Calculs (nombre de réponses / 700 × 100) : quartile 1 : 412 / 700 × 100 = 58,9 % ; quartile 2 : 498 / 700 × 100 = 71,1 % ; quartile 3 : 553 / 700 × 100 = 79,0 % ; quartile 4 : 602 / 700 × 100 = 86,0 %.

3. Écart absolu = 86,0 − 58,9 = 27,1 points. Rapport = 86,0 / 58,9 = 1,46. Les adultes les plus aisés sont 1,46 fois plus nombreux, en proportion, à se déclarer en bonne santé que les plus modestes.

4. La part des adultes en bonne santé augmente à chaque quartile de revenu : c'est un gradient social de santé, expression des inégalités sociales de santé. Conséquence : le projet doit être ouvert à tous mais renforcé pour les plus modestes (universalisme proportionné), en agissant aussi sur l'accès (prix, proximité) et pas seulement sur l'information.

Corrigé – Exercice 1.5

1. Légendes : 1 Santé humaine ; 2 maladies chroniques, carences, antibiorésistance ; 3 Santé animale ; 4 élevage, bien-être animal, zoonoses ; 5 Santé des écosystèmes ; 6 climat, sols, eau, biodiversité ; 7 Alimentation durable.

2. Définition (OHHLEP, 2021) : « une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ». Quadripartite : OMS, FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), OMSA (Organisation mondiale de la santé animale), PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement).

3. Repas végétariens : santé humaine (plus de fibres, moins d'acides gras saturés si le menu est équilibré) ; écosystèmes (moins d'émissions de gaz à effet de serre, les légumineuses fixent l'azote de l'air) ; santé animale (moindre pression sur l'élevage intensif). Volailles sans antibiotiques : santé animale (élevage qui doit prévenir les maladies autrement) ; santé humaine (limitation de la sélection de bactéries résistantes) ; écosystèmes (moins de résidus et de bactéries résistantes dans les sols et l'eau).

4. Vigilance : apport en protéines (associer légumineuses et céréales, prévoir œufs ou produits laitiers) et en fer (légumineuses avec une source de vitamine C) ; acceptabilité par les enfants (recettes, goût, textures) pour éviter le gaspillage ; grammages adaptés à l'âge.

Corrigé – Exercice 1.6

1. Dimension biologique : enfants de 3 à 6 ans (besoins de croissance, goût en construction). Dimension psychologique : parents qui se sentent jugés ; envie de faire plaisir à l'enfant. Dimension sociale : manque d'argent et de temps, logement sans four (11 familles sur 28, soit 39,3 %), offre alimentaire du quartier pauvre en produits frais.

2. La santé des enfants dépend de ressources de la vie quotidienne : revenu, logement équipé, commerces accessibles, temps disponible, confiance des parents. L'action doit renforcer ces ressources (compétences, accès, soutien entre parents) et pas seulement transmettre des informations.

3. Exemple d'introduction : « Depuis la Charte d'Ottawa (1986), la santé n'est plus seulement l'absence de maladie : c'est une ressource de la vie quotidienne, qui dépend des conditions de vie autant que des comportements. Au centre social, les familles disent manquer de temps et d'argent ; 11 des 28 familles ayant un enfant de 3 à 6 ans n'ont pas de four, et l'offre de fruits et légumes frais du quartier est limitée. Dans ce contexte, des conseils seuls ne suffiraient pas. Le projet « café des parents » propose donc un espace d'échange et de pratique, construit avec les familles, pour partager des idées de goûters simples, appréciés des enfants et peu coûteux, et pour faciliter l'accès aux produits frais du marché. »

4. Phrase : « certains se sentent jugés par l'école sur le contenu du goûter ». On évite tout message culpabilisant (« bons » et « mauvais » goûters), on part de ce que font déjà les parents, on valorise les réussites, on relit les supports avec la check-list éthique et non-stigmatisation.

Partie 2 – La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir la santé publique (Winslow, 1920) et la politique de santé (article L. 1411-1 du code de la santé publique).
- Distinguer l'approche clinique et l'approche de santé publique.
- Citer les missions de la santé publique et les relier à des actions concrètes en nutrition.
- Expliquer et calculer le paradoxe de la prévention (Rose, 1985) ; distinguer incidence et prévalence.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Santé publique : ensemble des savoirs, des savoir-faire et des actions organisées qui visent à maintenir et améliorer la santé de la population, en agissant collectivement sur ses déterminants (Winslow, 1920 : « la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé… »).
- Neuf missions : observer et surveiller ; veiller et alerter ; protéger ; promouvoir ; prévenir ; éduquer et informer ; organiser ; former, chercher, évaluer ; gouverner.
- Paradoxe de la prévention (Geoffrey Rose, 1985) : un grand nombre de personnes exposées à un petit risque peut produire plus de cas qu'un petit nombre de personnes à haut risque.
- Prévalence = cas existants / population à un moment donné. Incidence = nouveaux cas pendant une période / population à risque au début de la période.

Exercice 2.1 – Légender les missions de la santé publique (9 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une affiche pour présenter la santé publique aux étudiants de première année lors d'une journée portes ouvertes.

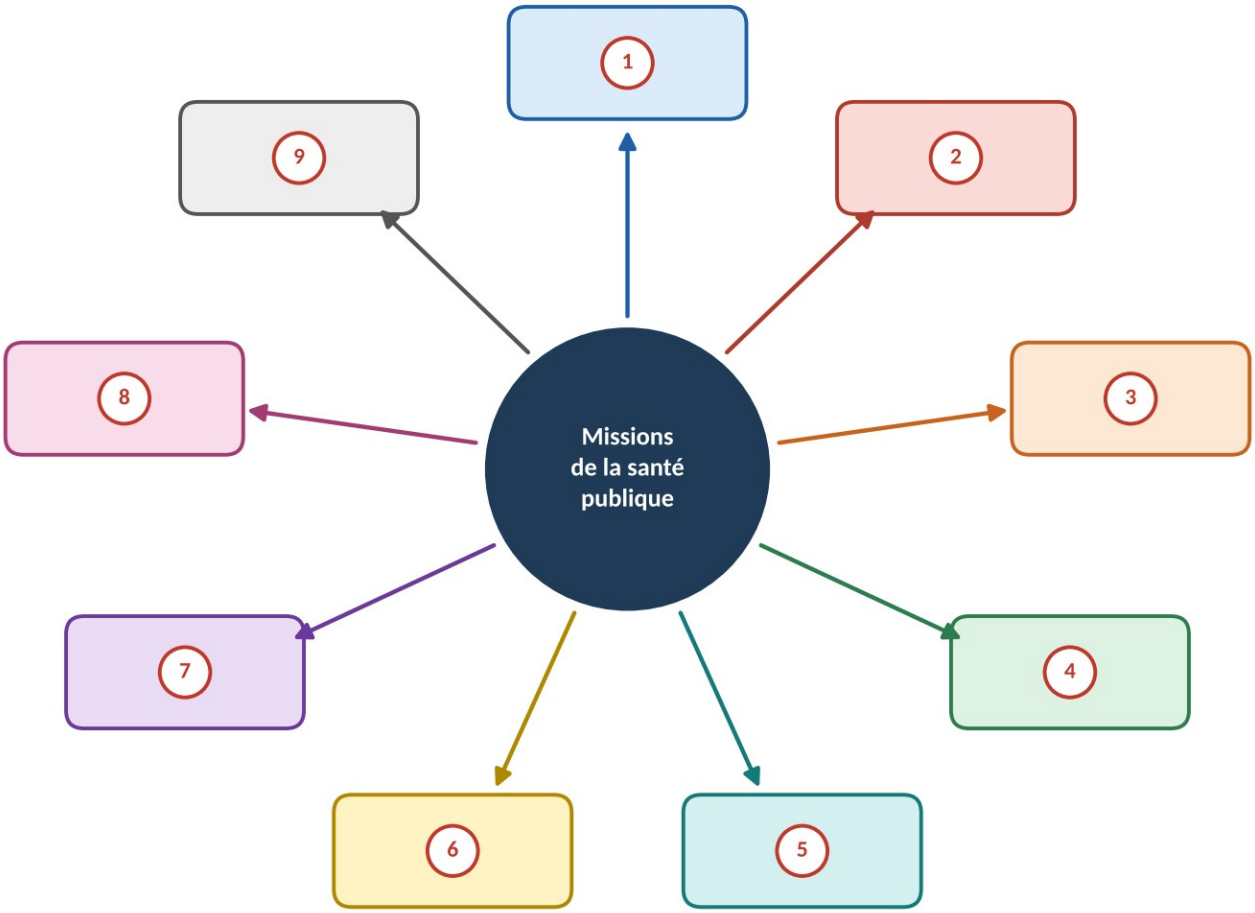


Figure 2.1 – Document 1 – Les missions de la santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)

2. Pour les missions 1, 2, 4, 5 et 6, donnez un exemple d'action en nutrition. (4,5 pts)

Ma réponse

Exercice 2.2 – Approche clinique ou approche de santé publique ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive), vous relevez les activités de la diététicienne pendant une semaine.

Document 1 – Activités de la semaine

a) Consultation d'un patient diabétique adressé par son médecin.

b) Analyse des données de corpulence des enfants des 4 écoles de la commune, transmises par la santé scolaire.

c) Animation d'un atelier « petits-déjeuners » pour toutes les classes de CE2 de la commune.

d) Bilan nutritionnel d'une patiente dénutrie à domicile.

e) Réunion avec la mairie pour installer des fontaines à eau dans les écoles.

f) Rédaction d'un plan de soins diététiques pour un patient insuffisant rénal.

g) Participation au comité de pilotage du contrat local de santé.

h) Conception d'un questionnaire sur l'alimentation des seniors de la commune.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque activité dans l'approche clinique ou dans l'approche de santé publique. (4 pts)

2. Comparez les deux approches selon 6 critères : cible, point de départ, objectif, leviers, acteurs, évaluation. (6 pts)

Ma réponse

Exercice 2.3 – Calculer le paradoxe de la prévention (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agglomération de 60 000 adultes (données fictives) veut réduire le nombre d'accidents vasculaires cérébraux (AVC). Deux stratégies sont proposées au conseil communautaire : un programme intensif pour les personnes hypertendues, ou une action sur toute la population pour réduire la consommation de sel (pain, restauration collective, ateliers).

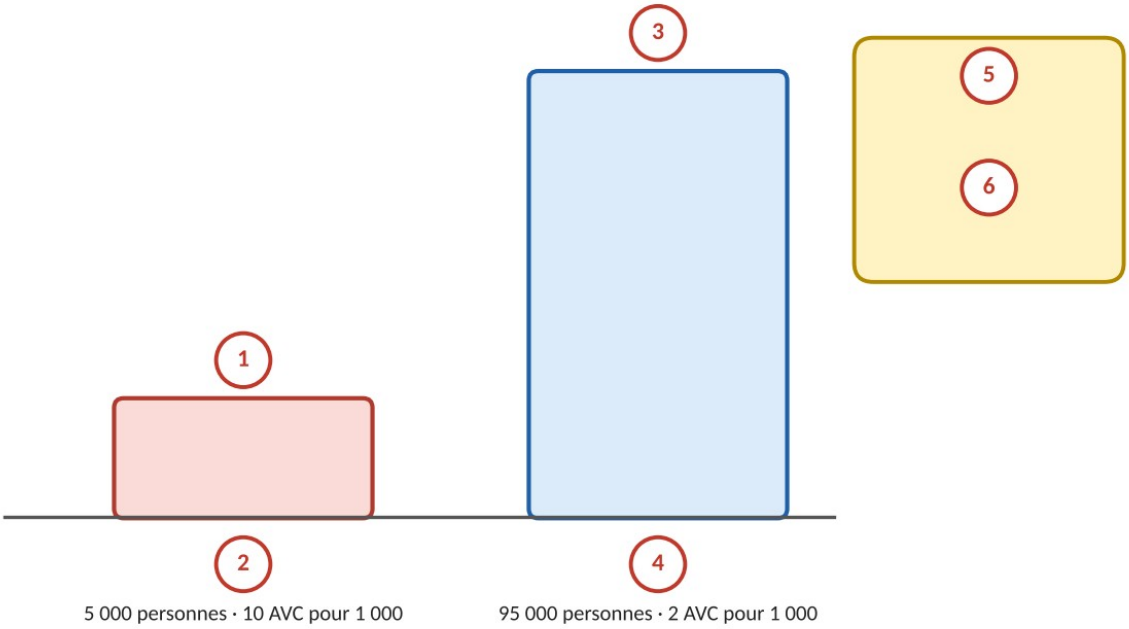


Figure 2.2 – Document 1 – Le paradoxe de la prévention, exemple du cours (schéma à légender)

Document 2 – Données de l'agglomération (fictives, risque sur 10 ans)

Groupe	Effectif	AVC attendus sur 10 ans pour 1 000 personnes
Hypertension sévère (haut risque)	6 000	12
Pression artérielle normale ou modérément élevée (faible risque)	54 000	3

Stratégie A (haut risque) : le programme intensif réduit de 30 % le risque des seules personnes à haut risque.

Stratégie B (population) : l'action sur le sel réduit de 10 % le risque de toute la population.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez le document 1. (3 pts)
2. Calculez le nombre d'AVC attendus sur 10 ans dans chaque groupe, puis au total. (3 pts)
3. Calculez la part des AVC qui surviennent dans le groupe à faible risque ; concluez. (2 pts)
4. Calculez le nombre d'AVC évités par la stratégie A et par la stratégie B. (3 pts)
5. Argumentez le choix d'une stratégie en citant le paradoxe de Rose et une limite de chaque stratégie. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.4 – Distinguer incidence et prévalence (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé scolaire d'une circonscription (données fictives) suit 2 400 enfants de CM1. En septembre, 312 enfants sont en surpoids (obésité comprise). En juin, 48 nouveaux enfants sont en surpoids parmi ceux qui ne l'étaient pas en septembre.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la prévalence et l'incidence. (2 pts)
2. Calculez la prévalence du surpoids en septembre. (2 pts)
3. Calculez l'incidence cumulée du surpoids entre septembre et juin, en précisant la population à risque. (3 pts)
4. Indiquez quel indicateur une action de prévention primaire cherche à faire baisser, et quel indicateur baisse avec une prévention secondaire ; justifiez. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.5 – Les missions de la santé publique face à une toxi-infection alimentaire collective (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un jeudi, 23 élèves et 2 agents d'une école primaire (structure fictive) présentent des vomissements et des diarrhées 4 à 6 heures après le déjeuner servi par la cuisine centrale. La directrice appelle le médecin scolaire.

Document 1 – Ce qui se passe dans les jours suivants

a) Le médecin déclare la toxi-infection alimentaire collective (TIAC) à l'agence régionale de santé.

b) Les plats témoins conservés par la cuisine centrale sont analysés.

c) La direction départementale chargée de la protection des populations inspecte la cuisine centrale.

d) Santé publique France intègre l'épisode dans la surveillance nationale des TIAC.

e) Le maire suspend la préparation des plats concernés jusqu'au rapport d'inspection.

f) La diététicienne de la cuisine centrale anime une formation sur le maintien en température pour les agents.

g) Une lettre d'information est envoyée aux familles.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la TIAC (au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire) et rappelez qu'elle est une maladie à déclaration obligatoire. (2 pts)

2. Associez chaque action du document 1 à une mission de la santé publique. (7 pts)

3. Indiquez le rôle du diététicien dans la prévention des TIAC en restauration collective. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 2.6 – Convaincre des élus d'une action populationnelle (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

En stage au service santé d'une ville de 35 000 habitants (structure fictive), vous devez préparer une note d'une page pour les élus. Le projet propose de travailler avec les boulangers volontaires de la ville pour réduire progressivement le sel du pain, et de réduire le sel des plats servis dans les cantines et au portage de repas des seniors. Un élu objecte : « Seuls les hypertendus sont concernés ; il suffit que leurs médecins s'en occupent. »

Document 1 – Extraits de textes

- Article L. 1411-1 du code de la santé publique : la politique de santé « tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales […] ».
- OMS : recommandation de moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Le pain fait partie des principaux contributeurs de l'apport en sel en France (études de consommation de l'ANSES).

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez à l'élu, avec le paradoxe de Rose, pourquoi une action sur toute la population est pertinente. (4 pts)

2. Montrez que le projet répond à la définition de la politique de santé du document 1. (3 pts)

3. Identifiez les missions de la santé publique mobilisées par le projet. (3 pts)

4. Rédigez la note d'une page aux élus : contexte, objectif, actions, partenaires, évaluation. (6 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 2.1

1. Légendes : 1 Observer et surveiller ; 2 Veiller et alerter ; 3 Protéger ; 4 Promouvoir la santé ; 5 Prévenir ; 6 Éduquer et informer ; 7 Organiser le système de santé ; 8 Former, chercher, évaluer ; 9 Gouverner.

2. Exemples : observer et surveiller : étude ESTEBAN ou INCA, enquêtes de santé scolaire ; veiller et alerter : déclaration d'une TIAC, nutrivigilance des compléments alimentaires ; promouvoir : installation de fontaines à eau, charte « Ville active du PNNS » ; prévenir : dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD ; éduquer et informer : atelier de lecture d'étiquettes, campagne « Manger Bouger ».

Corrigé – Exercice 2.2

1. Approche clinique : a, d, f. Approche de santé publique : b, c, e, g, h.

2. Comparaison :

Critère	Approche clinique	Approche de santé publique
Cible	Un individu, le patient	Une population ou un groupe
Point de départ	Une demande de soin, une prescription	Un diagnostic de situation (données, besoins)
Objectif	Guérir, soulager, accompagner	Maintenir et améliorer la santé du groupe, réduire les inégalités
Leviers	Bilan, diagnostic diététique, plan de soins, ETP	Environnements, politiques, communication, éducation, partenariats
Acteurs	Équipe soignante	Équipe pluridisciplinaire et intersectorielle
Évaluation	Évolution clinique du patient	Indicateurs de processus et de résultats sur le groupe

Corrigé – Exercice 2.3

1. Légendes du document 1 : 1 50 AVC ; 2 Groupe à haut risque ; 3 190 AVC ; 4 Groupe à faible risque ; 5 Paradoxe de la prévention ; 6 La majorité des cas vient du grand nombre de personnes à faible risque.

2. AVC attendus = effectif × risque / 1 000. Haut risque : 6 000 × 12 / 1 000 = 72 AVC. Faible risque : 54 000 × 3 / 1 000 = 162 AVC. Total : 72 + 162 = 234 AVC.

3. Part dans le groupe à faible risque = 162 / 234 × 100 = 69,2 %. Plus des deux tiers des AVC surviennent chez des personnes à faible risque, simplement parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses.

4. Stratégie A : 72 × 0,30 = 21,6, soit environ 22 AVC évités. Stratégie B : 234 × 0,10 = 23,4, soit environ 23 AVC évités.

5. La stratégie B évite autant ou un peu plus d'AVC alors que la réduction du risque individuel est faible (10 %) : c'est le paradoxe de Rose, une mesure qui apporte peu à chaque personne apporte beaucoup à la population. Limites : la stratégie A ne touche que 10 % de la population et ignore la majorité des cas ; la stratégie B apporte un bénéfice individuel faible, donc peu motivant, et doit être maintenue longtemps. Le mieux est de combiner les deux.

Corrigé – Exercice 2.4

1. Prévalence : nombre de cas existants dans une population à un moment donné, rapporté à cette population. Incidence : nombre de nouveaux cas apparus pendant une période, rapporté à la population à risque (non malade) au début de la période.

2. Prévalence en septembre = 312 / 2 400 × 100 = 13,0 %.

3. Population à risque = enfants sans surpoids en septembre = 2 400 − 312 = 2 088. Incidence cumulée = 48 / 2 088 × 100 = 2,3 % sur l'année scolaire.

4. La prévention primaire évite l'apparition de nouveaux cas : elle fait baisser l'incidence. La prévention secondaire repère et prend en charge tôt les cas existants, ce qui raccourcit la durée du problème : elle fait baisser la prévalence.

Corrigé – Exercice 2.5

1. TIAC : apparition d'au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. C'est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS.

2. a) Veiller et alerter ; b) observer (investigation, recherche de l'agent) et protéger ; c) protéger (contrôle de la sécurité sanitaire) ; d) observer et surveiller ; e) protéger (mesure de gestion du risque) ; f) éduquer et former ; g) informer.

3. Le diététicien participe au plan de maîtrise sanitaire (méthode HACCP, bonnes pratiques d'hygiène), forme les agents, vérifie les températures et la traçabilité, conserve les plats témoins, choisit des recettes et des procédés à moindre

risque et participe à l'investigation en cas de TIAC.

Corrigé – Exercice 2.6

1. L'hypertension et ses complications ne surviennent pas seulement chez les personnes déjà hypertendues : comme l'a montré Rose, le grand nombre de personnes à risque faible ou modéré produit une grande partie des cas. Réduire un peu le sel consommé par tous (pain, cantines, portage) déplace vers le bas la pression artérielle moyenne de toute la population et évite davantage de cas que l'action sur les seuls hypertendus. Les médecins restent indispensables pour les personnes à haut risque : les deux actions se complètent.

2. Le projet crée des conditions de vie favorables à la santé (pain et repas moins salés, sans effort individuel) ; il vise l'amélioration de l'état de santé de la population ; il réduit les inégalités, car il bénéficie à tous, y compris aux personnes qui ont moins accès à la prévention individuelle (seniors portés à domicile, enfants des cantines).

3. Promouvoir (environnement alimentaire), prévenir (prévention primaire universelle de l'hypertension), protéger, éduquer et informer (ateliers, communication), observer et évaluer (mesure du sel), gouverner (décision des élus, partenariat avec les boulangers).

4. Exemple de note : contexte (l'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour ; le pain est un contributeur majeur ; l'hypertension est un facteur de risque majeur d'AVC) ; objectif (réduire progressivement la teneur en sel du pain des boulangeries volontaires et des repas de la restauration municipale en 2 ans) ; actions (charte avec les boulangers, réduction par paliers pour préserver le goût, adaptation des recettes en cuisine centrale, ateliers « goût sans sel » avec les herbes et les épices, information des habitants) ; partenaires (boulangers, chambre de métiers, cuisine centrale, CCAS, ARS au titre du CLS) ; évaluation (teneur en sel mesurée ou déclarée, nombre de boulangeries engagées, ventes, satisfaction des convives, suivi des plaintes sur le goût).

Partie 3 – Problème de santé, danger, risque, facteurs de risque et de protection

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir problème de santé, danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection et population à risque.
- Identifier ces notions dans une situation professionnelle et calculer un risque simple.
- Hiérarchiser des problèmes de santé avec des critères explicites.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Danger : propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation capable de provoquer un effet néfaste.
- Exposition : contact entre la population et le danger (dose, durée, fréquence).
- Risque : probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition (risque = danger × exposition).
- Facteur de risque : caractéristique associée à une probabilité accrue de maladie, sans être forcément la cause. Facteur de protection : associé à une probabilité réduite.
- Critères de priorité d'un problème de santé : fréquence, gravité, évolution, coût, existence de moyens d'action efficaces, demande de la population.

Exercice 3.1 – Légender la chaîne du risque (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance de formation pour les animateurs d'un centre de loisirs sur la sécurité des goûters et l'alimentation des enfants.

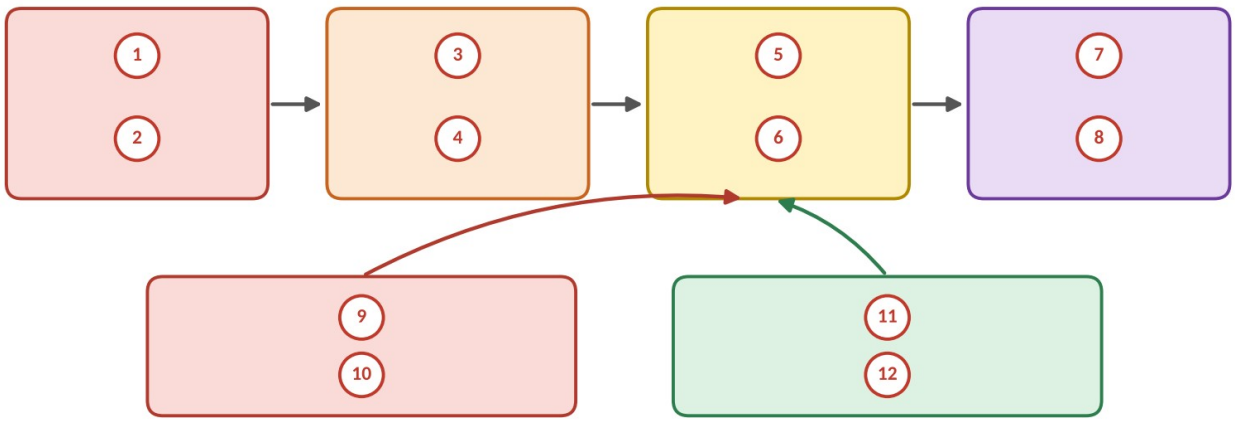


Figure 3.1 – Document 1 – Du danger au problème de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (6 pts)
2. Appliquez la chaîne au cas d'un enfant allergique à l'arachide qui participe à un goûter d'anniversaire : danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi, avec le même danger, le risque peut être nul. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 3.2 – Classer les notions (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix éléments relevés dans des situations de stage

a) Listeria monocytogenes. b) Consommation quotidienne de plats préparés riches en sel. c) Probabilité de développer une hypertension dans une population qui mange très salé. d) Allaitement maternel. e) Femmes enceintes face à la listériose. f) Sédentarité. g) Obésité des enfants d'un quartier, mesurée par la santé scolaire. h) Soutien social d'une personne âgée vivant seule. i) Faible revenu. j) Consommation de fruits, de légumes et de fibres.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque élément : problème de santé, danger, exposition, risque, facteur de risque, facteur de protection ou population à risque. (10 × 1 pt)

Ma réponse

Exercice 3.3 – Calculer et interpréter un risque (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un observatoire régional (données fictives) a suivi pendant 3 ans 1 200 adolescents de 12 ans sans surpoids au départ. Au début du suivi, 400 adolescents buvaient chaque jour au moins une boisson sucrée ; 800 n'en buvaient pas chaque jour.

Document 1 – Résultats après 3 ans

Groupe	Effectif au départ	Adolescents en surpoids après 3 ans
Boisson sucrée chaque jour	400	64
Pas de boisson sucrée chaque jour	800	72

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de devenir en surpoids en 3 ans dans chaque groupe. (3 pts)

2. Calculez le rapport des deux risques (risque relatif) et interprétez-le. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la boisson sucrée quotidienne est un facteur de risque, mais pas forcément la cause unique du surpoids ; citez deux autres facteurs qui peuvent intervenir. (3 pts)

4. Proposez une action de promotion de la santé et une action d'éducation pour la santé qui découlent de ce résultat. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 3.4 – La listériose chez la femme enceinte (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez avec la sage-femme de la PMI une séance collective pour des femmes enceintes. L'une d'elles dit : « Ma mère a mangé du fromage au lait cru pendant toutes ses grossesses et nous allons très bien. »

Document 1 – Informations de référence

La listériose est une infection due à Listeria monocytogenes, une bactérie présente dans l'environnement qui peut se multiplier au réfrigérateur. Elle est rare mais grave : chez la femme enceinte, elle peut provoquer une fausse couche, un accouchement prématuré ou une infection grave du nouveau-né. Les personnes les plus exposées à une forme grave sont les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Les aliments à éviter pendant la grossesse comprennent notamment les fromages au lait cru, les charcuteries à la coupe, les poissons fumés et les graines germées crues.

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez le danger, l'exposition, le risque et la population à risque. (4 pts)
2. Expliquez à cette femme pourquoi l'expérience de sa mère ne prouve pas l'absence de risque (rareté de l'événement, probabilité). (3 pts)
3. Proposez quatre conseils pratiques de prévention, formulés de façon positive. (4 pts)
4. Indiquez le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon) de cette séance. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 3.5 – Facteurs de risque et facteurs de protection dans un quartier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un quartier prioritaire (données fictives), la santé scolaire observe que 21 % des élèves de CM2 sont en surpoids, contre 15 % dans le reste de la ville. Un élu en conclut : « Le quartier rend les enfants gros. »

Document 1 – Observations du diagnostic de quartier

- Deux supermarchés discount et une supérette ; le marché a lieu une fois par semaine.
- Un city-stade fermé depuis deux ans ; peu d'espaces verts.
- Taux de chômage élevé ; beaucoup de familles monoparentales.
- Une association de parents très active ; un jardin partagé créé en 2024 ; une école qui participe à un programme de fruits à la récréation.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart de prévalence entre le quartier et le reste de la ville, en points et en rapport. (2 pts)

2. Expliquez pourquoi la phrase de l'élu est une erreur de raisonnement. (3 pts)

3. Classez les observations du document 1 en facteurs de risque et en facteurs de protection. (4 pts)

4. Proposez deux actions qui renforcent les facteurs de protection existants. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 3.6 – Hiérarchiser des problèmes de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage du contrat local de santé d'une communauté de communes (données fictives) dispose d'un budget pour une seule action de nutrition en 2027. Quatre problèmes ont été repérés. Votre tutrice vous demande de construire une grille de priorisation et de présenter un choix argumenté.

Document 1 – Notes attribuées par le groupe de travail (1 = faible, 3 = élevé)

Problème	Fréquence	Gravité	Évolution et coût	Faisabilité (moyens efficaces disponibles)	Demande de la population
Surpoids des enfants	3	2	2	2	2
Dénutrition des seniors à domicile	2	3	2	3	1
Insécurité alimentaire des familles	3	2	2	2	3
Faible consommation de légumineuses	3	1	1	3	1

Pondération retenue : fréquence × 2 ; gravité × 3 ; évolution et coût × 1 ; faisabilité × 2 ; demande × 1.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les critères habituels de priorisation d'un problème de santé et justifiez la pondération plus forte de la gravité. (3 pts)
2. Calculez le score pondéré de chaque problème et classez-les. (5 pts)
3. Discutez le résultat : écart entre les scores, subjectivité des notes, problème qui touche peu de personnes mais qui est grave. (4 pts)
4. Rédigez la recommandation au comité de pilotage en 5 lignes. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 3.1

1. Légendes : 1 Danger ; 2 propriété d'un agent capable de nuire ; 3 Exposition ; 4 contact : dose, durée, fréquence ; 5 Risque ; 6 probabilité de survenue de l'effet néfaste ; 7 Problème de santé ; 8 mesuré par des indicateurs ; 9 Facteurs de risque ; 10 augmentent la probabilité (sédentarité, boissons sucrées, faible revenu) ; 11 Facteurs de protection ; 12 diminuent la probabilité (fibres, activité physique, soutien social).

2. Danger : l'arachide (allergène). Exposition : ingestion de gâteaux ou de biscuits contenant de l'arachide ou des traces, au goûter. Risque : probabilité d'une réaction allergique grave (anaphylaxie) pendant le goûter. Facteur de risque : produits faits maison sans liste d'ingrédients, absence d'information des animateurs. Facteur de protection : projet d'accueil individualisé connu de l'équipe, lecture des étiquettes, goûter de l'enfant fourni par la famille, trousse d'urgence disponible.

3. Si l'exposition est nulle (aucun produit contenant de l'arachide n'est consommé), le risque est nul même si le danger existe : risque = danger × exposition.

Corrigé – Exercice 3.2

a) Danger. b) Exposition. c) Risque. d) Facteur de protection. e) Population à risque. f) Facteur de risque. g) Problème de santé. h) Facteur de protection. i) Facteur de risque. j) Facteur de protection.

Corrigé – Exercice 3.3

1. Risque = nouveaux cas / effectif au départ. Boisson sucrée quotidienne : 64 / 400 = 0,16, soit 16 %. Sans boisson sucrée quotidienne : 72 / 800 = 0,09, soit 9 %.

2. Risque relatif = 0,16 / 0,09 = 1,78. Les adolescents qui boivent une boisson sucrée chaque jour ont 1,78 fois plus de risque de devenir en surpoids en 3 ans que les autres.

3. Une association statistique ne prouve pas la causalité : les adolescents qui boivent des boissons sucrées chaque jour peuvent aussi avoir d'autres caractéristiques (sédentarité, temps d'écran, sommeil court, revenus plus faibles, grignotage) qui expliquent une partie de l'écart. Ces facteurs de confusion doivent être pris en compte (chapitre 16).

4. Promotion de la santé : fontaines à eau et suppression de l'offre de boissons sucrées dans les lieux fréquentés par les jeunes (milieux favorables). Éducation pour la santé : atelier sur le sucre caché dans les boissons et fabrication d'eaux aromatisées maison.

Corrigé – Exercice 3.4

1. Danger : Listeria monocytogenes. Exposition : consommation d'aliments pouvant être contaminés (fromages au lait cru, charcuteries à la coupe, poissons fumés, graines germées crues). Risque : probabilité de listériose et de ses complications (fausse couche, prématurité, infection du nouveau-né). Population à risque : les femmes enceintes (ainsi que les personnes âgées et immunodéprimées).

2. La listériose est rare : la plupart des femmes qui consomment ces aliments n'auront pas de listériose, mais celles qui l'ont peuvent avoir des conséquences très graves. L'absence d'accident chez une personne ne prouve pas l'absence de risque : c'est une probabilité, faible, avec une gravité élevée. On ne dramatise pas, on explique.

3. Conseils positifs : « Choisissez les fromages à pâte pressée cuite (comté, emmental) et les fromages pasteurisés » ; « Préférez la charcuterie préemballée et consommez-la rapidement après ouverture » ; « Faites bien cuire viandes et poissons » ; « Nettoyez le réfrigérateur régulièrement et vérifiez sa température (4 °C au plus) » ; « Lavez soigneusement les légumes et les herbes aromatiques ».

4. Prévention primaire (OMS) ; prévention sélective (Gordon), car elle vise un groupe exposé à un risque particulier, sans maladie.

Corrigé – Exercice 3.5

1. Écart absolu = 21 − 15 = 6 points ; rapport = 21 / 15 = 1,4. La prévalence est 1,4 fois plus élevée dans le quartier.

2. Habiter le quartier est associé à une prévalence plus forte, mais ce n'est pas le quartier en lui-même qui cause le surpoids : ce sont des déterminants (revenus, offre alimentaire, espaces d'activité physique, stress, temps disponible) plus fréquents dans le quartier. Confondre association et causalité conduit à des actions inefficaces et stigmatisantes.

3. Facteurs de risque : offre alimentaire limitée (discount, supérette, marché hebdomadaire) ; city-stade fermé, peu d'espaces verts ; chômage et monoparentalité (ressources et temps limités). Facteurs de protection : association de parents active (soutien social, action communautaire) ; jardin partagé ; programme de fruits à la récréation.

4. Exemples : s'appuyer sur l'association de parents pour co-construire des ateliers de cuisine avec les légumes du jardin partagé ; plaider auprès de la mairie pour rouvrir le city-stade avec des animations sportives gratuites ; étendre le programme de fruits à toutes les écoles du quartier.

Corrigé – Exercice 3.6

1. Critères : fréquence (prévalence, incidence), gravité (mortalité, handicap, qualité de vie), évolution et coût, existence de moyens d'action efficaces et faisables, demande et acceptabilité de la population, inégalités. La gravité est pondérée plus fortement, car un problème grave a des conséquences lourdes (décès, perte d'autonomie) même s'il touche moins de personnes.

2. Scores pondérés (fréquence × 2 + gravité × 3 + évolution × 1 + faisabilité × 2 + demande × 1) : surpoids des enfants : 3 × 2 + 2 × 3 + 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 1 = 20 ; dénutrition des seniors : 2 × 2 + 3 × 3 + 2 × 1 + 3 × 2 + 1 × 1 = 22 ; insécurité alimentaire : 3 × 2 + 2 × 3 + 2 × 1 + 2 × 2 + 3 × 1 = 21 ; légumineuses : 3 × 2 + 1 × 3 + 1 × 1 + 3 × 2 + 1 × 1 = 17. Classement : dénutrition des seniors (22), insécurité alimentaire (21), surpoids des enfants (20), légumineuses (17).

3. Les trois premiers scores sont très proches (22, 21, 20) : un point de différence sur une seule note changerait le classement. Les notes sont subjectives et doivent être justifiées par des données (prévalences, demandes recueillies). La dénutrition touche moins de personnes, mais sa gravité (chutes, hospitalisations, perte d'autonomie) explique son rang. Le groupe peut aussi chercher une action qui répond à deux problèmes à la fois (par exemple l'insécurité alimentaire des seniors isolés).

4. Recommandation : « La grille place en tête la dénutrition des seniors à domicile (22 points), suivie de près par l'insécurité alimentaire des familles (21) et le surpoids des enfants (20). Nous recommandons une action de repérage et de prévention de la dénutrition, avec le portage de repas, le CCAS et les infirmiers libéraux, car le problème est grave et des moyens efficaces existent. Les scores étant proches, l'insécurité alimentaire sera traitée en 2028 ; les notes seront révisées avec les données du diagnostic. »

Partie 4 – Les modes d'intervention en santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer et distinguer les quatre modes d'intervention : surveillance et veille, promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé.
- Classer une action selon les niveaux de prévention de l'OMS et selon Gordon.
- Citer les 5 domaines d'action et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa et les illustrer en nutrition.
- Appliquer l'universalisme proportionné ; choisir une approche éducative participative et non stigmatisante.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Prévention primaire : avant la maladie, réduit l'incidence. Secondaire : maladie débutante, réduit la prévalence (dépistage). Tertiaire : maladie installée, réduit les complications et les récidives (ETP). Quaternaire (Jamoulle, 1986) : éviter la surmédicalisation.
- Gordon (1983) : universelle (toute la population), sélective (groupe à risque sans signe), indiquée (personnes présentant des facteurs de risque ou des signes).
- Charte d'Ottawa (21 novembre 1986) : 5 domaines (politique publique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services de santé) et 3 stratégies (plaider, conférer les moyens, servir de médiateur).
- Universalisme proportionné (Marmot, 2010) : action pour tous, intensité proportionnelle au désavantage.
- Éducation pour la santé : nutritionnelle, alimentaire, sensorielle ; approches informative, persuasive, participative.

Exercice 4.1 – Légender les niveaux de prévention (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter, en réunion d'équipe d'une PMI, les classifications de la prévention pour qualifier les actions du service.

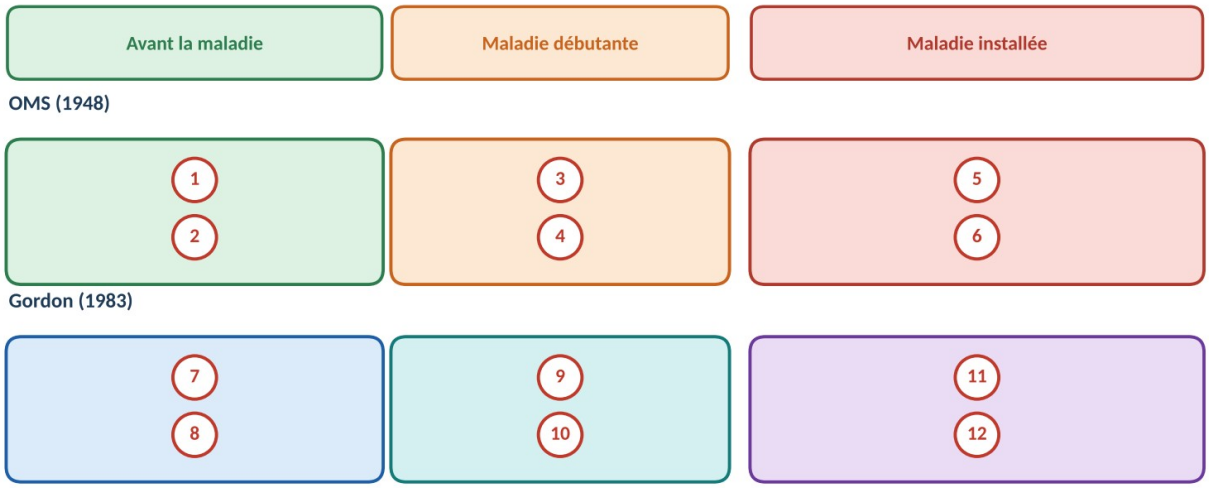


Figure 4.1 – Document 1 – Les niveaux de prévention selon l'OMS et selon Gordon (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)

2. Pour chacun des trois niveaux de l'OMS, donnez un exemple d'action en nutrition. (3 pts)

3. Définissez la prévention quaternaire et donnez un exemple en nutrition. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.2 – Les 5 domaines et les 3 stratégies de la Charte d'Ottawa (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville de 25 000 habitants (structure fictive) a signé la charte « Ville active du PNNS ». Vous devez montrer aux élus que leur plan d'action couvre bien les cinq domaines de la Charte d'Ottawa.

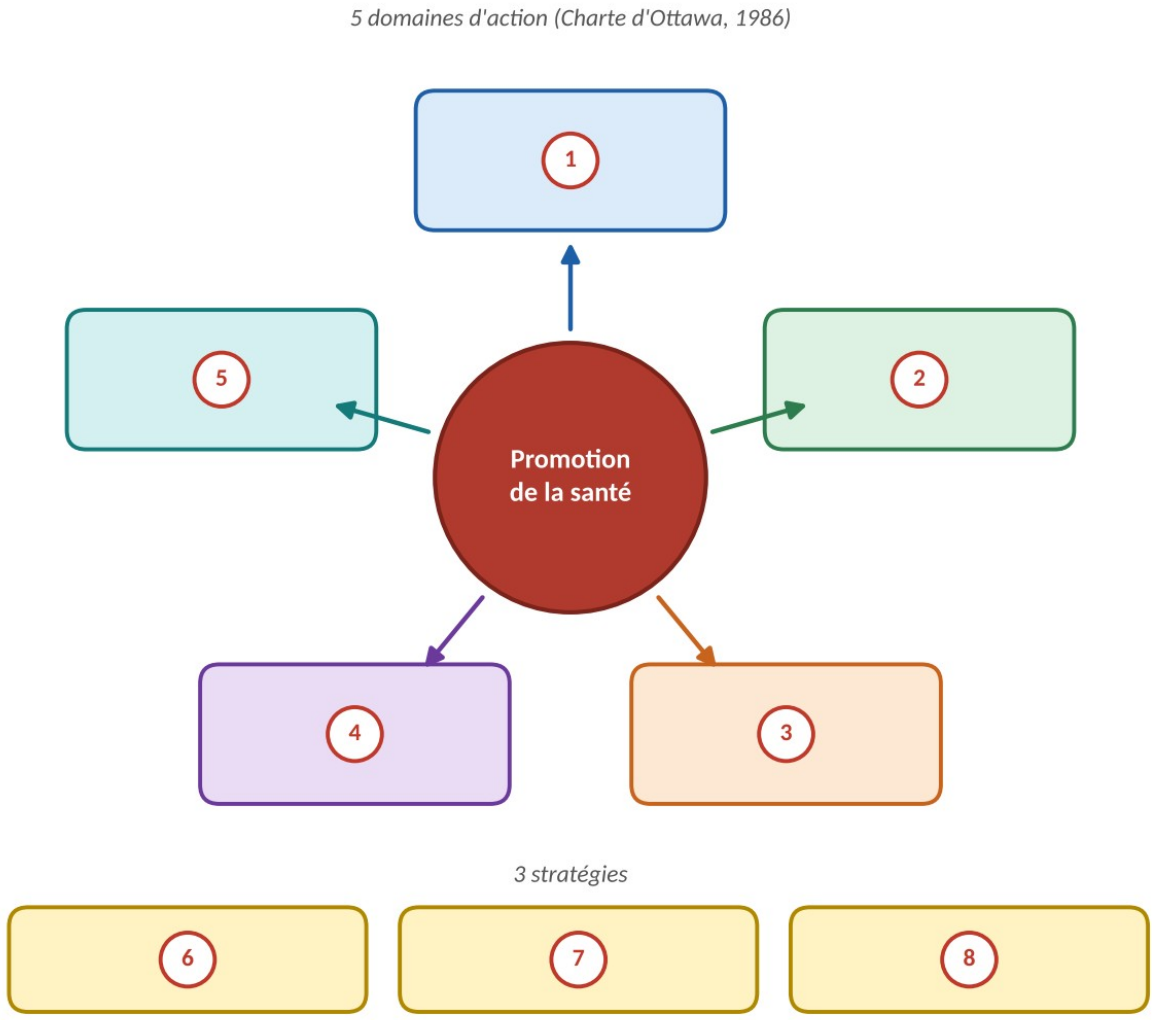


Figure 4.2 – Document 1 – La Charte d'Ottawa (schéma à légender)

Document 2 – Actions du plan municipal

a) Fontaines à eau dans toutes les écoles. b) Ateliers « cuisine du marché » pour les habitants. c) Jardin partagé géré par une association d'habitants. d) Délibération du conseil municipal fixant 50 % de produits durables dont 20 % de bio en restauration scolaire. e) Consultation de prévention nutritionnelle à la maison de santé. f) Rencontres entre maraîchers, cuisine centrale et parents d'élèves pour choisir les produits. g) Formation des animateurs périscolaires à l'éducation au goût. h) Présentation aux élus des données de corpulence des enfants pour obtenir le financement.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (4 pts)
2. Classez chaque action du document 2 dans un domaine d'action de la Charte. (5 pts)
3. Associez les actions f et h à une des trois stratégies ; justifiez. (2 pts)
4. Rappelez la définition de la promotion de la santé selon la Charte d'Ottawa. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.3 – Qualifier une action (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Six actions observées sur un territoire

a) Une campagne nationale de radio rappelle les repères du PNNS.

b) La santé scolaire mesure le poids et la taille des élèves de grande section et oriente les enfants dont la courbe de corpulence remonte tôt.

c) Une diététicienne anime 6 ateliers « petit budget » pour les familles bénéficiaires d'une épicerie sociale.

d) Un service de diabétologie organise un programme d'éducation thérapeutique déclaré à l'ARS.

e) Santé publique France publie les résultats d'une enquête nationale sur la corpulence.

f) Un EHPAD pèse chaque résident à l'entrée puis tous les mois et dose l'albumine sur prescription.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque action, indiquez le mode d'intervention, le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon), quand c'est possible. (9 pts)
2. Expliquez pourquoi l'action d ne relève pas de l'éducation pour la santé. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.4 – Appliquer l'universalisme proportionné à la cantine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une commune (données fictives) facture actuellement le repas de cantine 3,00 € à toutes les familles. Elle étudie une tarification sociale en quatre tranches selon le quotient familial. Un enfant mange 140 repas par an à la cantine.

Document 1 – Tarification étudiée et revenus types

Tranche	Revenu mensuel type de la famille	Prix du repas proposé
Tranche 1	1 300 €	1,00 €
Tranche 2	2 200 €	2,20 €
Tranche 3	3 400 €	3,40 €
Tranche 4	5 500 €	4,50 €

À vous de jouer – Questions

1. Définissez l'universalisme proportionné et citez son auteur. (2 pts)

2. Calculez, pour chaque tranche, le coût annuel de la cantine et sa part dans le revenu annuel, avec le tarif unique de 3,00 € puis avec la tarification proposée. (6 pts)

3. Interprétez les résultats : quelle tarification est la plus équitable ? (3 pts)

4. Montrez que la tarification sociale est une action universelle d'intensité proportionnée ; proposez une autre mesure qui renforce l'accès des familles de la tranche 1. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 4.5 – Choisir une approche éducative (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Un collège veut agir sur la consommation de boissons sucrées des élèves de 5e. Trois propositions sont faites.

Document 1 – Trois propositions

Proposition 1 : une affiche montrant un adolescent en surpoids avec le slogan « Le soda, c'est ça qui t'attend ».

Proposition 2 : un dépliant indiquant la quantité de sucre de 10 boissons et les repères du PNNS.

Proposition 3 : trois séances où les élèves mesurent le sucre de leurs boissons préférées, inventent des recettes d'eaux aromatisées, les font goûter aux autres classes et proposent au conseil d'administration l'installation d'une fontaine.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez l'approche éducative de chaque proposition et indiquez sa principale limite ou son principal intérêt. (6 pts)
2. Réécrivez le slogan de la proposition 1 pour qu'il soit positif et non stigmatisant. (2 pts)
3. Montrez que la proposition 3 combine plusieurs domaines de la Charte d'Ottawa et développe des compétences psychosociales. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 4.6 – Construire une réponse combinant les quatre modes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle régionale (structure fictive) vous recrute en stage. Elle veut un programme « Bien manger au travail » pour les 1 200 salariés de ses adhérents entreprises, et un programme pour ses adhérents atteints de diabète de type 2. Le directeur pense « faire la même chose pour tout le monde, avec une conférence et un livret ».

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez au directeur pourquoi les deux publics relèvent de modes d'intervention différents. (4 pts)
2. Proposez, pour les salariés, une action relevant de chacun des quatre modes d'intervention (surveillance et veille, promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé). (6 pts)
3. Indiquez, pour les adhérents diabétiques, le cadre réglementaire de l'éducation thérapeutique et le rôle possible du diététicien. (3 pts)
4. Critiquez l'idée d'une conférence et d'un livret identiques pour tous, en citant deux principes de la promotion de la santé. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 4.1

1. Légendes : 1 Prévention primaire ; 2 réduit l'incidence ; 3 Prévention secondaire ; 4 réduit la prévalence ; 5 Prévention tertiaire ; 6 réduit les complications et récidives ; 7 Universelle ; 8 toute la population ; 9 Sélective ; 10 groupe à risque, sans signe ; 11 Indiquée ; 12 personnes présentant des signes.

2. Primaire : atelier cuisine, repères du PNNS, réduction du sel dans le pain. Secondaire : dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD, repérage du rebond d'adiposité précoce. Tertiaire : prise en charge diététique d'un diabète, ETP.

3. La prévention quaternaire (Marc Jamoulle, 1986) protège les personnes de la surmédicalisation et des interventions inutiles ou nocives. Exemple : éviter un régime d'exclusion du gluten sans diagnostic de maladie cœliaque, ou des compléments alimentaires inutiles.

Corrigé – Exercice 4.2

1. Légendes : 1 Élaborer une politique publique saine ; 2 Créer des milieux favorables ; 3 Renforcer l'action communautaire ; 4 Acquérir des aptitudes individuelles ; 5 Réorienter les services de santé ; 6 Plaider ; 7 Conférer les moyens ; 8 Servir de médiateur.

2. a) Milieux favorables. b) Aptitudes individuelles. c) Action communautaire. d) Politique publique saine. e) Réorientation des services de santé. f) Action communautaire (et politique publique). g) Aptitudes individuelles (des professionnels relais) et réorientation des services. h) Politique publique saine, par le plaidoyer.

3. f : servir de médiateur, car on concilie les intérêts des producteurs, de la cuisine et des familles. h : plaider, car on présente des données aux décideurs pour obtenir une décision et des moyens.

4. « La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. »

Corrigé – Exercice 4.3

1. a) Éducation pour la santé informative et prévention primaire universelle. b) Prévention secondaire (repérage précoce), type indiqué, car les enfants repérés présentent un signe ; elle s'appuie sur la surveillance. c) Éducation pour la santé (alimentaire) et prévention primaire sélective. d) Éducation thérapeutique du patient : soin et prévention tertiaire. e) Surveillance épidémiologique (pas de niveau de prévention : elle produit les données). f) Prévention secondaire : dépistage de la dénutrition.

2. L'ETP s'adresse à des patients atteints d'une maladie chronique, pour les aider à gérer leur maladie et leur traitement ; elle relève du soin, est encadrée par l'article L. 1161-1 du code de la santé publique (loi HPST du 21 juillet 2009) et se fait dans des programmes déclarés à l'ARS. L'éducation pour la santé vise des personnes bien portantes.

Corrigé – Exercice 4.4

1. Universalisme proportionné (Michael Marmot, 2010) : les actions sont destinées à toute la population, mais leur intensité augmente avec le niveau de désavantage social.

2. Coût annuel = 140 × prix ; revenu annuel = revenu mensuel × 12 ; part = coût / revenu annuel × 100.

Tranche	Revenu annuel	Tarif unique : coût	Tarif unique : part du revenu	Tarif proposé : coût	Tarif proposé : part du revenu
1	15 600 €	420 €	2,69 %	140 €	0,90 %
2	26 400 €	420 €	1,59 %	308 €	1,17 %
3	40 800 €	420 €	1,03 %	476 €	1,17 %
4	66 000 €	420 €	0,64 %	630 €	0,95 %

3. Avec le tarif unique, l'effort demandé est 4 fois plus lourd pour la tranche 1 (2,69 %) que pour la tranche 4 (0,64 %) : 2,69 / 0,64 = 4,2. Avec la tarification proposée, l'effort est proche pour toutes les familles (de 0,90 % à 1,17 %). La tarification sociale est plus équitable : elle réduit le frein financier pour les familles modestes.

4. La cantine reste ouverte à tous (universelle), mais l'aide est plus forte pour les familles les plus modestes (intensité proportionnée). Mesure complémentaire : information des familles et inscription simplifiée par le CCAS, petit-déjeuner à l'école dans les quartiers prioritaires, ou aide aux repas des vacances scolaires.

Corrigé – Exercice 4.5

1. Proposition 1 : approche persuasive par la peur ; elle culpabilise, stigmatise les adolescents en surpoids et peut renforcer les inégalités. Proposition 2 : approche informative ; utile, mais savoir ne suffit pas à changer un comportement. Proposition 3 : approche participative ; elle part des élèves, développe leurs compétences et leur pouvoir d'agir, mais demande du temps et des compétences d'animation.

2. Exemple : « L'eau, ça se personnalise : invente ta boisson ! » ou « Envie de fraîcheur ? Teste nos eaux aux fruits. »

3. Domaines d'Ottawa : aptitudes individuelles (mesurer le sucre, cuisiner), action communautaire (élèves acteurs auprès des autres classes), milieux favorables et politique de l'établissement (fontaine votée au conseil d'administration). Compétences psychosociales : pensée critique (analyse des boissons et de la publicité), créativité (recettes), communication et coopération (présentation aux autres classes), prise de décision (proposition au conseil d'administration).

Corrigé – Exercice 4.6

1. Les salariés sont des personnes a priori bien portantes : l'action relève de la promotion de la santé, de la prévention primaire et de l'éducation pour la santé. Les adhérents diabétiques sont des patients : l'accompagnement de leur maladie relève de l'éducation thérapeutique, donc du soin et de la prévention tertiaire, avec des objectifs, des méthodes et un cadre différents.

2. Surveillance et veille : questionnaire anonyme sur les habitudes alimentaires au travail, suivi des données de la restauration ; veille sur les recommandations. Promotion de la santé : amélioration de l'offre de la restauration d'entreprise et des distributeurs, pauses repas protégées, espaces pour déjeuner. Prévention : dépistage proposé du risque cardiovasculaire lors d'une journée santé, avec orientation vers le médecin (prévention secondaire), ou action sur le sel (primaire). Éducation pour la santé : ateliers « gamelle équilibrée », lecture d'étiquettes, défis collectifs.

3. Cadre : article L. 1161-1 du code de la santé publique (loi HPST du 21 juillet 2009), recommandations de la HAS (2007), programmes déclarés à l'ARS. Le diététicien formé à l'ETP peut participer au bilan éducatif partagé et animer des séances (adapter son alimentation, lire les étiquettes, gérer les repas à l'extérieur).

4. Une conférence et un livret pour tous relèvent d'une approche informative, peu efficace seule ; ils ne partent pas des besoins de chaque public. Principes à citer : participation des personnes concernées dès le diagnostic ; action sur les milieux et pas seulement sur les comportements ; universalisme proportionné ; non-stigmatisation.

Partie 5 – Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les acteurs aux niveaux international, européen, national, régional et local, et citer leur rôle en nutrition.
- Trouver la bonne source de données pour un diagnostic.
- Construire un plan de financement et une carte des partenaires d'un projet.
- Repérer les conflits d'intérêts dans un outil ou un partenariat.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Santé publique France (créée le 1er mai 2016) : surveillance, veille et alerte, prévention et promotion de la santé, « Manger Bouger », Nutri-Score, ESTEBAN, Géodes.
- ANSES (2010) : évaluation des risques, références nutritionnelles, études INCA, table Ciqual, Oqali, nutrivigilance.
- HAS (2004) : recommandations de bonne pratique, ETP. HCSP (2004) : expertise et avis (repères alimentaires, recommandations pour le PNNS 5). CNA (1985) : concertation.
- DGS (ministère chargé de la santé) : pilote le PNNS. DGAL (ministère chargé de l'agriculture) : pilote le PNA, sécurité sanitaire des aliments. DGCCRF : loyauté, étiquetage.
- ARS (loi HPST du 21 juillet 2009, créées en 2010) : projet régional de santé, financement de la prévention, contrats locaux de santé. DRAAF : PNA en région, projets alimentaires territoriaux.

Exercice 5.1 – Légender la carte des acteurs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dès la première semaine de stage, votre tutrice vous demande d'établir la carte des acteurs qui interviennent en nutrition, du niveau international au niveau local.

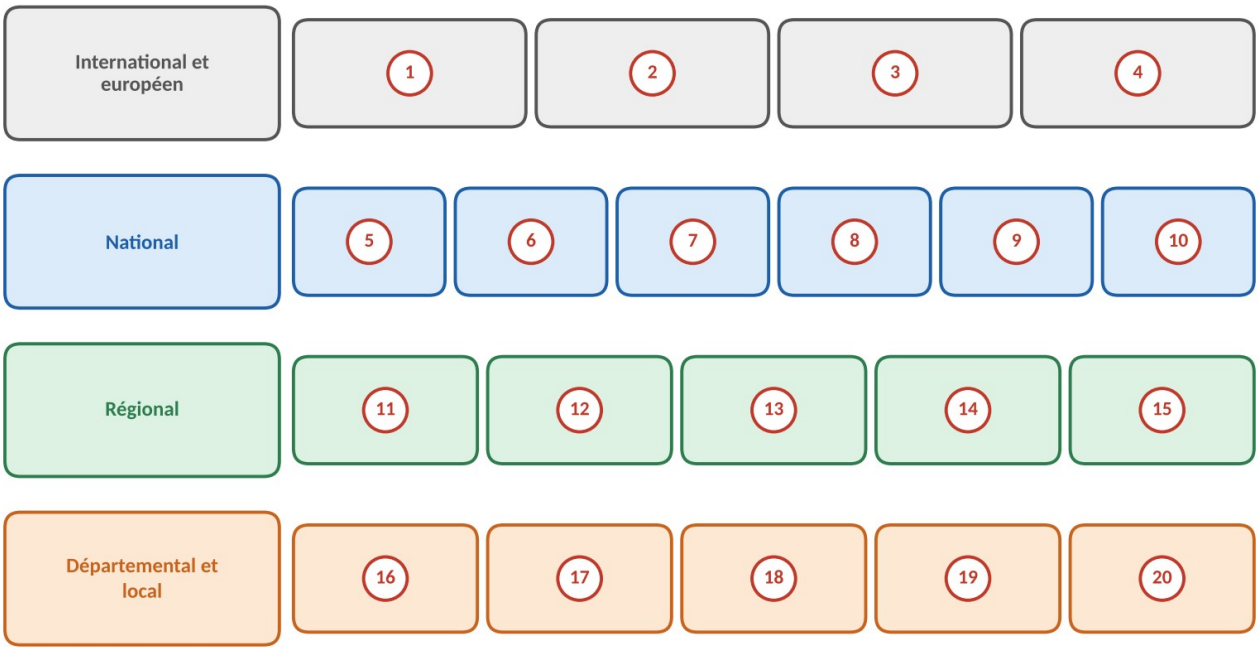


Figure 5.1 – Document 1 – Les acteurs de la santé publique en nutrition (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 20 du document 1, sachant que : la ligne 1 comprend deux agences des Nations unies, l'autorité européenne d'évaluation des risques et l'institution qui propose la réglementation européenne ; la ligne 2 comprend la direction qui pilote le PNNS, deux agences sanitaires, deux instances d'expertise et la direction qui pilote la sécurité sanitaire des aliments ; la ligne 3 comprend l'agence qui pilote la santé en région, la collectivité qui gère les lycées, le service de l'État chargé de l'alimentation en région, l'observatoire et la structure d'appui méthodologique ; la ligne 4 comprend les acteurs de proximité. (10 pts)

Ma réponse

Exercice 5.2 – Qui fait quoi ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix missions

a) Publier les références nutritionnelles et réaliser les études INCA. b) Gérer en France le logo Nutri-Score et le programme « Manger Bouger ». c) Publier une recommandation de bonne pratique sur la dénutrition. d) Rendre un avis d'expertise sur les repères alimentaires des enfants. e) Réunir producteurs, distributeurs, consommateurs et professionnels de santé pour rendre des avis. f) Contrôler la loyauté de l'étiquetage d'un produit. g) Évaluer les risques alimentaires au niveau européen. h) Signer un contrat local de santé avec une commune. i) Reconnaître un projet alimentaire territorial. j) Piloter le programme national pour l'alimentation.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque mission à l'organisme qui en est chargé. (10 × 1 pt)

Ma réponse

Exercice 5.3 – Trouver la bonne source de données (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez le diagnostic d'un projet « Bien manger, bien grandir » dans une communauté d'agglomération. Vous devez trouver des données nationales de comparaison et des données locales.

Document 1 – Données recherchées

a) Prévalence de l'obésité mesurée chez les adultes en France. b) Consommations alimentaires détaillées des enfants et des adultes. c) Part de la population sous le seuil de pauvreté dans l'agglomération. d) Causes médicales de décès dans le département. e) Corpulence des élèves de grande section, de CM2 et de 3e. f) Composition nutritionnelle des aliments servis à la cantine. g) Indicateurs de santé déjà rassemblés pour le territoire. h) Données de santé consultables en ligne et cartographiées.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez, pour chaque donnée, une source et l'organisme qui la produit. (8 pts)

2. Expliquez pourquoi ESTEBAN (2014-2016) reste citée en 2026 et ce que changera l'enquête Albane. (2 pts)

3. Indiquez trois règles pour citer une donnée dans un dossier E5. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 5.4 – Construire un plan de financement (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (structure fictive) prépare un projet d'ateliers « Cuisine et budget » pour 40 familles sur un an. Le budget total est de 12 400 €. Vous devez compléter le plan de financement à joindre aux demandes de subvention.

Document 1 – Financements obtenus ou demandés

Financeur	Montant
ARS (appel à projets prévention)	5 000 €
Commune (au titre du contrat local de santé)	3 000 €
CAF	2 500 €
DREETS (programme « Mieux manger pour tous »)	1 400 €
Fonds propres du centre social	500 €

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez que le plan de financement est équilibré et calculez la part de chaque financeur. (4 pts)

2. Justifiez la légitimité de chaque financeur pour ce projet. (5 pts)

3. Indiquez ce que le centre social devra fournir à ses financeurs en fin de projet. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 5.5 – Repérer un conflit d'intérêts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de produits laitiers sucrés propose gratuitement à une école un « kit pédagogique sur le petit-déjeuner », avec des affiches, un jeu et des échantillons de ses produits. La directrice vous demande votre avis.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un conflit d'intérêts et expliquez pourquoi ce kit en présente un. (3 pts)

2. Proposez cinq critères pour évaluer la qualité d'un outil pédagogique en nutrition. (5 pts)

3. Indiquez où trouver des outils pédagogiques validés et sans lien commercial. (2 pts)

4. Rédigez la réponse à la directrice en 4 lignes. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 5.6 – Construire la carte des partenaires d'un projet (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service développement durable d'une communauté de communes rurale (structure fictive) qui porte un projet alimentaire territorial. Le projet veut augmenter la part de produits locaux dans les 6 cantines du territoire et créer des ateliers cuisine pour les familles. Vous devez identifier les partenaires et leur rôle.

Document 1 – Acteurs rencontrés

Élus de la communauté de communes ; cuisinières des 6 cantines ; parents d'élèves ; chambre d'agriculture ; 12 maraîchers et éleveurs ; DRAAF ; ARS (délégation départementale) ; enseignants ; centre social ; épicerie sociale ; association de jardiniers ; supermarché du bourg.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les acteurs dans une matrice « pouvoir de décision / intérêt pour le projet » (quatre cases) ; indiquez la stratégie d'implication pour chaque case. (6 pts)
2. Précisez le rôle attendu de la DRAAF, de l'ARS et de la chambre d'agriculture. (3 pts)
3. Proposez une instance de pilotage et sa composition. (3 pts)
4. Montrez que le projet est intersectoriel et qu'il s'inscrit dans l'approche « Une seule santé ». (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 5.1

Ligne 1 : 1 OMS ; 2 FAO ; 3 EFSA ; 4 Commission européenne. Ligne 2 : 5 Ministère chargé de la santé (DGS) ; 6 Santé publique France ; 7 ANSES ; 8 HAS ; 9 HCSP ; 10 Ministère chargé de l'agriculture (DGAL). Ligne 3 : 11 ARS ; 12 Conseil régional ; 13 DRAAF ; 14 ORS ; 15 Promotion Santé (ex-IREPS). Ligne 4 : 16 Conseil départemental (PMI) ; 17 Communes et CCAS ; 18 Éducation nationale ; 19 CPTS, maisons de santé ; 20 Associations. L'ordre des cases d'une même ligne n'est pas exigé si les acteurs sont justes.

Corrigé – Exercice 5.2

a) ANSES. b) Santé publique France. c) HAS (avec la FFN pour la dénutrition de la personne âgée, 2021). d) HCSP (avis de 2020 sur les repères des enfants). e) CNA. f) DGCCRF. g) EFSA. h) ARS. i) DRAAF (ministère chargé de l'agriculture). j) DGAL (ministère chargé de l'agriculture).

Corrigé – Exercice 5.3

1. a) ESTEBAN, Santé publique France (2014-2016 : 17 % d'obésité chez les 18-74 ans). b) INCA 3, ANSES (2014-2015). c) Insee (taux de pauvreté, données locales). d) CépiDc de l'Inserm (causes médicales de décès). e) Enquêtes de santé scolaire, Drees. f) Table Ciqual, ANSES. g) ORS (portraits de territoire) ou diagnostic du contrat local de santé. h) Géodes, Santé publique France.

2. ESTEBAN fournit les dernières données de corpulence mesurée (et non déclarée) en population générale. L'enquête Albane, lancée en 2025 par Santé publique France et l'ANSES, associera régulièrement questionnaires, mesures et examens : elle remplacera ESTEBAN et INCA pour suivre l'état nutritionnel.

3. Citer l'organisme, le titre de l'étude et l'année de recueil ; vérifier que c'est la donnée la plus récente ; distinguer donnée mesurée et déclarée ; préciser le champ (âge, territoire).

Corrigé – Exercice 5.4

1. Total = 5 000 + 3 000 + 2 500 + 1 400 + 500 = 12 400 € : le plan est équilibré. Parts (montant / 12 400 × 100) : ARS 40,3 % ; commune 24,2 % ; CAF 20,2 % ; DREETS 11,3 % ; fonds propres 4,0 %.

2. ARS : finance la prévention et la promotion de la santé (fonds d'intervention régional), en lien avec le projet régional de santé. Commune : porteuse du contrat local de santé et de l'action sociale (CCAS). CAF : finance les centres sociaux et le soutien aux familles. DREETS : programme « Mieux manger pour tous » (aide alimentaire de qualité). Fonds propres : montrent l'engagement du porteur.

3. Bilan d'activité (actions réalisées, participants), bilan d'évaluation (indicateurs de résultats), bilan financier (dépenses réelles justifiées), supports produits, perspectives.

Corrigé – Exercice 5.5

1. Un conflit d'intérêts existe quand un intérêt secondaire (ici commercial : vendre des produits laitiers sucrés) peut influencer un objectif principal (l'éducation des enfants). Le kit fait la promotion de la marque et risque de présenter ses produits comme indispensables au petit-déjeuner.

2. Critères : auteur identifié et indépendant, sans lien commercial ; contenu exact et à jour (repères du PNNS) ; adapté à l'âge et à la culture du public ; démarche participative, non culpabilisante ; objectifs pédagogiques explicites ; évalué ou testé ; absence de marque et de publicité.

3. Pédagothèques et centres de ressources des structures régionales Promotion Santé, outils de Santé publique France (mangerbouger.fr), outils de l'Éducation nationale (Éduscol).

4. « Ce kit est fourni par une entreprise qui vend les produits présentés : il présente un conflit d'intérêts et ne doit pas être utilisé, en particulier les échantillons. Je vous propose des outils indépendants des pédagothèques de Promotion Santé et de Santé publique France, que je peux adapter avec les enseignants. »

Corrigé – Exercice 5.6

1. Matrice : pouvoir fort et intérêt fort (élus, DRAAF financeur du PAT) : associer étroitement, co-décider. Pouvoir fort et intérêt plus faible (ARS, supermarché du bourg) : tenir informés, solliciter sur des points précis. Pouvoir faible et intérêt fort (cuisinières, parents, maraîchers et éleveurs, centre social, épicerie sociale, association de jardiniers, enseignants) : faire participer aux groupes de travail. Pouvoir faible et intérêt faible : informer régulièrement. Le

classement se discute ; l'important est de le justifier.

2. DRAAF : reconnaissance du PAT et financements du programme national pour l'alimentation. ARS : volet santé (financement d'ateliers, lien avec le contrat local de santé). Chambre d'agriculture : mise en relation avec les producteurs, structuration de l'offre locale.

3. Comité de pilotage présidé par l'élu référent : élus, DRAAF, ARS, chambre d'agriculture, représentant des cuisinières, représentant des parents, producteurs, centre social ; réunion 2 fois par an ; groupes de travail thématiques.

4. Intersectoriel : agriculture, éducation, santé, social, économie locale, environnement. « Une seule santé » : santé humaine (qualité des repas), santé des écosystèmes (produits de saison, circuits courts, moins de transport, agriculture durable), santé animale (conditions d'élevage des éleveurs locaux).

Partie 6 – Les politiques publiques de santé et leur déclinaison territoriale

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir une politique publique et distinguer loi, règlement, stratégie, plan et financement.
- Décrire les étapes d'une politique publique, de la mise à l'agenda à l'évaluation.
- Expliquer l'architecture SNS, PRS (COS, SRS, PRAPS), CLS, et situer le PAT et le contrat de ville.
- Relier une action locale aux politiques nationales et régionales ; répondre à un appel à projets.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Stratégie nationale de santé (article L. 1411-1-1 du code de la santé publique) : dernière adoptée 2018-2022 ; projet 2023-2033 non adopté en mai 2026.
- Projet régional de santé (article L. 1434-1) élaboré par l'ARS : cadre d'orientation stratégique sur 10 ans, schéma régional de santé sur 5 ans, PRAPS (programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis).
- Contrat local de santé (article L. 1434-10) : contrat entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants.
- Projet alimentaire territorial : loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 ; reconnu par le ministère chargé de l'agriculture.
- Étapes : mise à l'agenda, élaboration, décision, mise en œuvre, pilotage et suivi, évaluation.

Exercice 6.1 – Légender l'architecture de la politique régionale de santé (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la partie « contexte » de votre dossier E5 et voulez montrer au jury comment votre action locale s'inscrit dans la politique de santé.

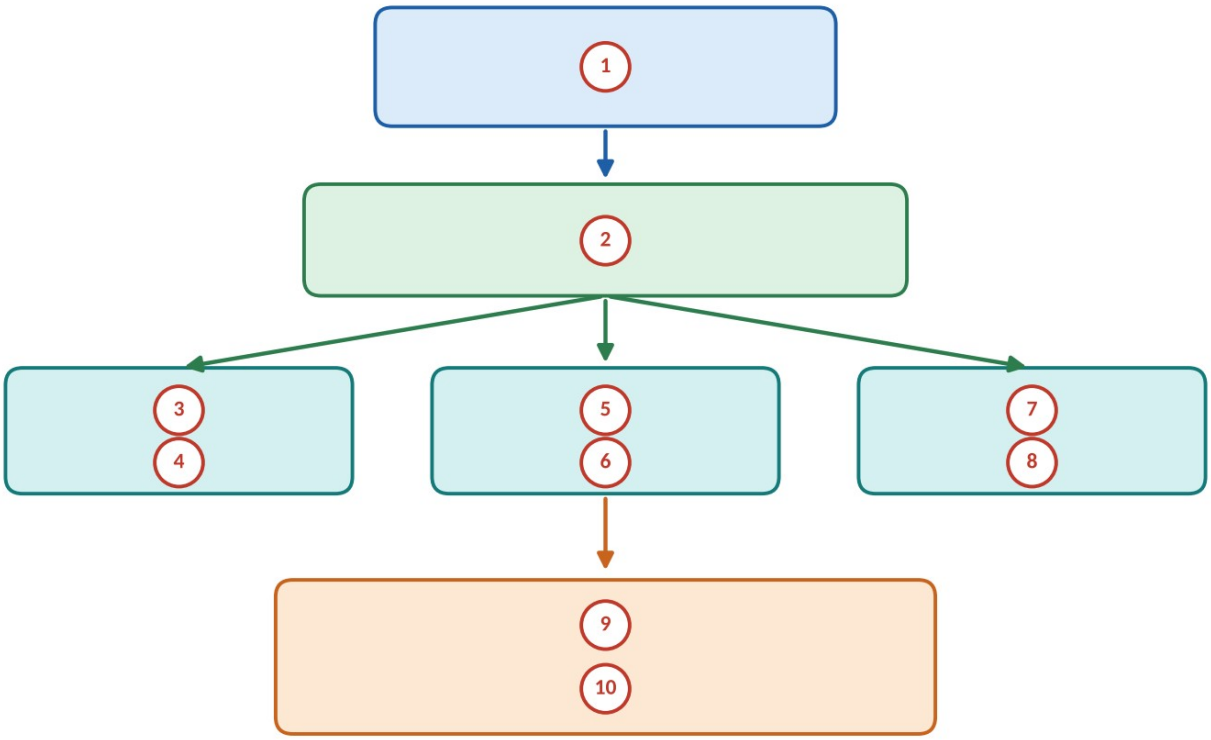


Figure 6.1 – Document 1 – De la stratégie nationale au contrat local de santé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés du document 1. (5 pts)

2. Expliquez le rôle du PRAPS pour un projet auprès de personnes en situation de précarité. (2 pts)

3. Indiquez où trouver le PRS de votre région et le contrat local de santé de votre lieu de stage. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 6.2 – Reconnaître les outils d'une politique publique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Document 1 – Dix textes et dispositifs

a) Loi EGalim du 30 octobre 2018. b) Arrêté du 14 mars 2025 sur le Nutri-Score. c) Projet de stratégie nationale de santé 2023-2033. d) PNNS 5 (2026-2030). e) Fonds d'intervention régional des ARS. f) SNANC 2025-2030. g) Décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas scolaires. h) Loi Climat et résilience du 22 août 2021. i) Programme « Mieux manger pour tous ». j) PNA 4 (2026-2030).

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque élément : loi, règlement (décret ou arrêté), stratégie, plan ou programme, financement. (10 × 1 pt)

Ma réponse

Exercice 6.3 – Les étapes d'une politique publique : l'exemple du PNNS 5 (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Événements dans le désordre

a) Le HCSP publie en juin 2025 ses recommandations pour le futur programme. b) Les ARS financent en région des actions qui déclinent le programme. c) Les données de surveillance montrent depuis les années 1990 une hausse du surpoids des enfants et un fort gradient social. d) Le programme est présenté le 8 avril 2026. e) Un comité de suivi examine chaque année des indicateurs (part des produits affichant le Nutri-Score, allaitement à la naissance). f) Une évaluation indépendante du programme préparera le PNNS suivant. g) Le PNNS 4 (2019-2023) est évalué, et une concertation réunit ARS, associations et chercheurs.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les événements dans l'ordre des étapes d'une politique publique, en nommant chaque étape. (7 pts)

2. Citez trois instances capables d'évaluer une politique de santé. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi l'évaluation est le début du cycle suivant. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 6.4 – Analyser une fiche-action de contrat local de santé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice coordonne le contrat local de santé d'une intercommunalité (structure fictive). Elle vous demande de relire une fiche-action avant le comité de pilotage.

Document 1 – Fiche-action n° 4 « Bien manger à tout âge » (extrait)

Constat : « Les habitants mangent mal. » Objectif : « Sensibiliser la population à l'alimentation. » Actions : conférences dans les mairies ; distribution de dépliants ; un stand au forum des associations. Porteur : à définir. Partenaires : tous. Budget : à voir. Indicateurs : « nombre de personnes sensibilisées ». Calendrier : 2025-2028.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre faiblesses de la fiche-action. (4 pts)

2. Réécrivez le constat et l'objectif à partir de données de diagnostic que vous inventerez de façon réaliste (en les signalant comme fictives). (4 pts)

3. Proposez trois indicateurs (processus, résultat, satisfaction) avec une valeur cible. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 6.5 – Relier une action locale aux politiques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans une PMI d'un département (structure fictive), vous animez des ateliers « premiers repas de bébé » pour des parents en situation de précarité.

À vous de jouer – Questions

1. Reliez cette action à chacun des niveaux suivants, en citant un texte ou un dispositif précis : international, national (stratégie), national (programme), régional, local. (6 pts)
2. Rédigez la phrase d'inscription du projet dans les politiques, telle qu'elle figurera dans votre dossier. (3 pts)
3. Indiquez les sources que le jury attend pour ces références et la vérification à faire avant de les citer. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 6.6 – Répondre à un appel à projets de l'ARS (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide à domicile (structure fictive) veut répondre à l'appel à projets « Prévention et promotion de la santé » de l'ARS pour prévenir la dénutrition des personnes âgées qu'elle accompagne. Elle suit 420 personnes de 75 ans et plus ; un repérage fait par les aides à domicile a montré que 63 d'entre elles ont perdu du poids récemment selon leurs proches.

Document 1 – Budget prévisionnel envisagé

Formation des 30 aides à domicile au repérage (2 sessions × 650 €) ; ateliers « repas plaisir » en petits groupes (12 ateliers × 180 €) ; balances pour le suivi du poids (15 × 40 €) ; livret pour les aidants (420 exemplaires × 1,50 €) ; coordination par une diététicienne (60 heures × 35 €).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des personnes repérées et indiquez la limite de ce repérage. (2 pts)

2. Calculez le budget total et la part de chaque poste. (4 pts)

3. Montrez l'inscription du projet dans les politiques en vigueur (PNNS 5, PRS, recommandations de la HAS). (3 pts)

4. Formulez l'objectif général et deux objectifs spécifiques. (4 pts)

5. Indiquez les engagements éthiques du projet (consentement, données de poids, non-stigmatisation). (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 6.1

1. Légendes : 1 Stratégie nationale de santé ; 2 Projet régional de santé (élaboré par l'ARS) ; 3 Cadre d'orientation stratégique ; 4 10 ans ; 5 Schéma régional de santé ; 6 5 ans ; 7 PRAPS (plus démunis) ; 8 5 ans ; 9 Contrat local de santé ; 10 ARS + collectivité (article L. 1434-10 du CSP).

2. Le PRAPS fixe les actions régionales pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies : un projet auprès d'un public précaire peut s'y référer pour justifier sa priorité et demander un financement.

3. PRS : site internet de l'ARS de la région (rubrique « Projet régional de santé »). CLS : site de l'ARS ou de la collectivité, ou demande auprès du coordinateur du CLS ; vérifier les dates de validité.

Corrigé – Exercice 6.2

Loi : a, h. Règlement : b (arrêté), g (décret). Stratégie : c (encore à l'état de projet en mai 2026), f. Plan ou programme : d, j. Financement : e, i (programme de financement de l'aide alimentaire).

Corrigé – Exercice 6.3

1. Ordre : c) mise à l'agenda (des données font du problème un problème public) ; g) puis a) élaboration (évaluation du programme précédent, concertation, expertise du HCSP) ; d) décision et adoption ; b) mise en œuvre ; e) pilotage et suivi ; f) évaluation.

2. HCSP, IGAS, Cour des comptes (et des équipes de recherche indépendantes).

3. L'évaluation mesure ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné ; ses conclusions servent de diagnostic pour le programme suivant : c'est un cycle d'amélioration continue.

Corrigé – Exercice 6.4

1. Faiblesses : constat vague et jugeant, sans donnée chiffrée ni source ; objectif non mesurable et sans échéance ; actions uniquement informatives (conférences, dépliants), peu efficaces seules ; porteur, partenaires et budget non définis ; indicateur imprécis ; aucun public prioritaire.

2. Exemple (données fictives) : constat : « Dans l'intercommunalité, 19 % des élèves de CM2 sont en surpoids (contre 15 % dans le département, santé scolaire 2025) et 42 % des seniors de plus de 75 ans vivent seuls (Insee). » Objectif : « D'ici fin 2028, faire participer 300 familles et 150 seniors des communes prioritaires à au moins 3 ateliers d'éducation alimentaire et améliorer de 20 % la part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 4 fois par semaine. »

3. Processus : nombre d'ateliers réalisés (cible : 40 sur 4 ans). Résultat : part des participants qui déclarent cuisiner des légumes au moins 4 fois par semaine (cible : + 20 %). Satisfaction : part des participants satisfaits ou très satisfaits (cible : 80 %).

Corrigé – Exercice 6.5

1. International : recommandation de l'OMS d'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. National, stratégie : SNANC 2025-2030 (accès de tous à une alimentation plus saine) (la SNS 2023-2033 n'est encore qu'un projet). National, programme : PNNS 5 (2026-2030), actions sur les « 1000 premiers jours » et l'allaitement ; programme « 1000 premiers jours » lancé en 2020. Régional : PRS de l'ARS et son PRAPS. Local : missions de PMI du conseil départemental ; contrat local de santé si la commune en a un.

2. Exemple : « Ce projet s'inscrit dans le programme des 1000 premiers jours et dans le PNNS 5 (2026-2030), qui fait des enfants et de la réduction des inégalités sociales en nutrition une priorité, ainsi que dans le PRAPS du projet régional de santé, qui vise l'accès à la prévention des personnes en situation de précarité. »

3. Sources officielles et datées : site du ministère chargé de la santé, mangerbouger.fr, site de l'ARS, Légifrance. Vérifier que le texte est en vigueur à la date de l'épreuve, citer son titre exact et sa date, éviter les synthèses non officielles pour les chiffres.

Corrigé – Exercice 6.6

1. Part repérée = 63 / 420 × 100 = 15,0 %. Limite : perte de poids rapportée par les proches, sans pesée ni critère validé ; il faut un repérage selon les critères de la HAS (2021) et une orientation vers le médecin traitant pour le diagnostic.

2. Formation : 2 × 650 = 1 300 € ; ateliers : 12 × 180 = 2 160 € ; balances : 15 × 40 = 600 € ; livret : 420 × 1,50 = 630 € ;

coordination : 60 × 35 = 2 100 €. Total = 1 300 + 2 160 + 600 + 630 + 2 100 = 6 790 €. Parts : formation 19,1 % ; ateliers 31,8 % ; balances 8,8 % ; livret 9,3 % ; coordination 30,9 % (la somme fait 99,9 % à cause des arrondis).

3. PNNS 5 : prévention de la dénutrition des personnes âgées parmi ses mesures ; PRS : axe de prévention de la perte d'autonomie ; HAS et FFN (2021) : diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus.

4. Objectif général : prévenir la dénutrition des personnes de 75 ans et plus accompagnées par l'association. Objectifs spécifiques : d'ici 12 mois, 100 % des aides à domicile savent repérer les signes d'alerte de la dénutrition et orienter ; d'ici 12 mois, 80 % des personnes repérées ont été orientées vers leur médecin traitant et ont participé à au moins un atelier.

5. Information et consentement de la personne (et de l'aidant), pesée seulement avec accord et dans le respect de la dignité, données de poids conservées de façon confidentielle et sécurisée et transmises uniquement au médecin avec accord, messages valorisant le plaisir de manger et non culpabilisants, respect des habitudes et des choix.

Partie 7 – Les politiques nutritionnelles de santé publique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Retracer l'histoire des politiques nutritionnelles, du PNNS 1 (2001) au PNNS 5 (2026-2030).
- Présenter la SNANC 2025-2030, le PNNS 5 et le PNA 4, et leurs liens.
- Calculer les taux EGalim d'une restauration collective ; utiliser les repères alimentaires de Santé publique France.
- Présenter le Nutri-Score et ses limites ; argumenter une diversification des protéines.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- PNNS 1 (2001-2005), PNNS 2 (2006-2010), PNNS 3 (2011-2015, prolongé jusqu'en 2018), PNNS 4 (2019-2023), PNNS 5 (2026-2030, lancé le 8 avril 2026 : 3 axes, 20 mesures).
- SNANC 2025-2030 : article 265 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 ; publiée le 11 février 2026 ; elle oriente le PNNS (ministère chargé de la santé) et le PNA (ministère chargé de l'agriculture).
- Loi EGalim (30 octobre 2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio, en valeur d'achat hors taxes ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire.
- Nutri-Score : logo facultatif de A à E, adopté par l'arrêté du 31 octobre 2017 ; nouvel algorithme rendu applicable par l'arrêté du 14 mars 2025.
- Repères adultes (Santé publique France, 2019) : augmenter (fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque, activité physique), aller vers (féculents complets, huiles de colza, de noix, d'olive, poisson, 2 produits laitiers par jour, produits de saison), réduire (alcool, boissons sucrées, produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés, charcuterie 150 g par semaine, viande hors volaille 500 g par semaine, sel).

Exercice 7.1 – Légender la frise des politiques nutritionnelles (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

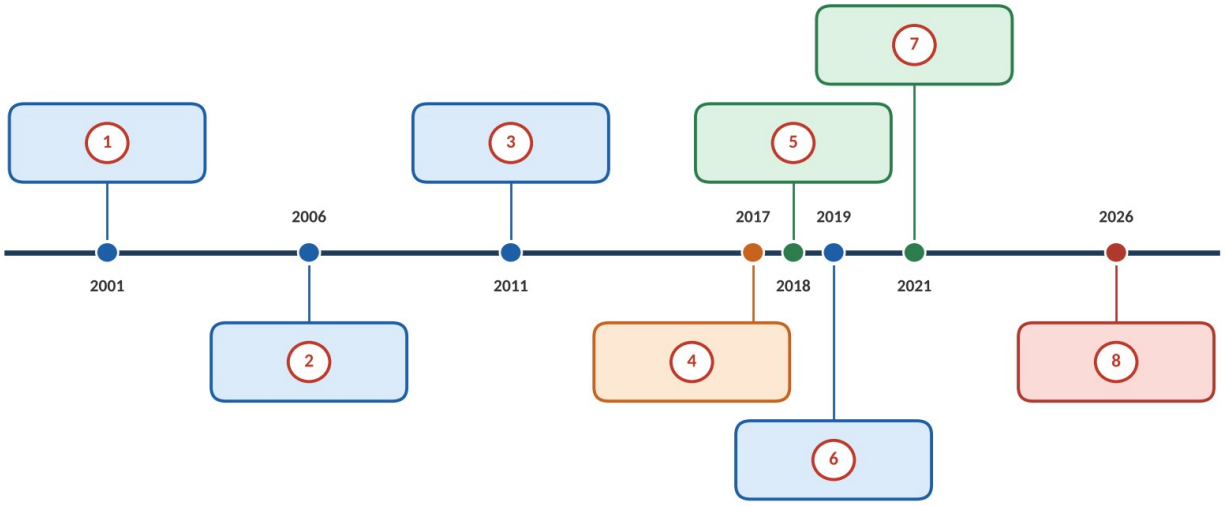


Figure 7.1 – Document 1 – Les grandes étapes des politiques nutritionnelles en France (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les cases 1 à 8 de la frise : nom du programme ou du texte et sa date ou sa période. (8 pts)

Ma réponse

Exercice 7.2 – Présenter le PNNS 5 et la SNANC (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

En réunion d'équipe, une animatrice vous demande : « Le PNNS, la SNANC, le PNA, c'est la même chose ? Lequel il faut citer ? »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le lien entre la SNANC, le PNNS 5 et le PNA 4 (texte de référence, ministère pilote, période). (4 pts)

2. Citez les trois axes du PNNS 5. (3 pts)

3. Citez trois objectifs chiffrés annoncés pour le PNNS 5. (3 pts)

4. Indiquez la précaution à prendre avant de citer un chiffre du PNNS 5 dans votre dossier. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 7.3 – Calculer les taux EGalim d'une cantine (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service de restauration scolaire d'une commune (données fictives). La commune doit télédéclarer ses achats de l'année sur la plateforme « ma cantine ».

Document 1 – Achats de denrées de l'année (hors taxes)

Catégorie d'achats	Montant
Total des achats de denrées	184 000 €
dont produits issus de l'agriculture biologique	31 280 €
dont produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP, IGP), non bio	29 440 €
dont produits de la pêche avec écolabel, non bio	11 040 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de produits bio et le taux de produits durables et de qualité (le bio en fait partie). (4 pts)
2. Comparez aux obligations de la loi EGalim et calculez, à budget constant, le montant d'achats à faire basculer pour atteindre chaque seuil. (4 pts)
3. Proposez deux leviers pour atteindre les objectifs sans augmenter le prix du repas. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 7.4 – Utiliser les repères alimentaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un stand de prévention dans une entreprise, un salarié de 45 ans décrit sa semaine habituelle.

Document 1 – Semaine habituelle déclarée

Charcuterie : 300 g par semaine. Viande hors volaille : 700 g par semaine. Légumes secs : jamais. Fruits et légumes : 3 portions par jour. Boissons sucrées : 2 verres par jour. Pain : uniquement blanc. Poisson : une fois par mois. Huile : tournesol uniquement. Produits laitiers : 2 par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Comparez chaque élément aux repères de Santé publique France ; calculez les dépassements de charcuterie et de viande. (6 pts)
2. Proposez trois changements prioritaires, formulés de façon positive et réaliste. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi ce conseil individuel, donné sur un stand, ne suffit pas et ce que l'entreprise peut faire de plus. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 7.5 – Le Nutri-Score (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier en supermarché, une participante vous dit : « Les céréales de mon fils sont notées A, donc elles ne sont pas transformées et il peut en manger autant qu'il veut. »

Document 1 – Objectifs annoncés du PNNS 5 sur le Nutri-Score

Part des Français utilisant le Nutri-Score : de 33 % à 40 %. Part du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score : de 62 % à 75 %.

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le Nutri-Score : ce qu'il mesure, son caractère obligatoire ou non, les textes français, les changements du nouvel algorithme. (4 pts)
2. Relevez les deux erreurs de la participante et corrigez-les. (3 pts)
3. Calculez la hausse en points et en pourcentage pour chacun des deux objectifs du document 1. (3 pts)
4. Proposez une activité d'atelier pour apprendre à utiliser le Nutri-Score. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 7.6 – Argumenter une diversification des protéines (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale (structure fictive) sert 450 repas par jour dans les écoles d'une commune, 36 semaines par an. Elle sert déjà un menu végétarien par semaine. Le comité du projet alimentaire territorial propose un deuxième repas végétarien hebdomadaire, à base de légumineuses, et de réinvestir l'économie réalisée dans des produits bio locaux.

Document 1 – Données de coût (prix construits pour le sujet)

Plat carné remplacé : 70 g de viande crue par enfant, à 12,00 € le kg. Plat de légumineuses : 60 g de lentilles sèches par enfant, à 3,60 € le kg. On néglige les autres ingrédients, identiques dans les deux plats.

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les obligations de la loi EGalim et de la loi Climat et résilience sur les menus végétariens et la diversification des protéines en restauration scolaire. (3 pts)

2. Calculez le coût de la portion de viande et de la portion de lentilles, l'économie par repas, puis l'économie annuelle. (5 pts)

3. Présentez les arguments « Une seule santé » et SNANC du projet. (4 pts)

4. Indiquez les conditions de réussite nutritionnelles et d'acceptabilité qui relèvent du diététicien. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 7.1

1 PNNS 1 (2001-2005) ; 2 PNNS 2 (2006-2010) ; 3 PNNS 3 (2011-2015, prolongé) ; 4 Nutri-Score (arrêté du 31 octobre 2017) ; 5 Loi EGalim (30 octobre 2018) ; 6 PNNS 4 (2019-2023) ; 7 Loi Climat et résilience (22 août 2021) ; 8 SNANC (11 février 2026) et PNNS 5 (2026-2030).

Corrigé – Exercice 7.2

1. La SNANC 2025-2030, prévue par l'article 265 de la loi Climat et résilience et publiée le 11 février 2026, fixe les orientations de la politique de l'alimentation durable et de la nutrition. Elle est déclinée par deux programmes 2026-2030 : le PNNS 5, piloté par le ministère chargé de la santé (DGS), et le PNA 4, piloté par le ministère chargé de l'agriculture. Dans un dossier, on cite la SNANC comme cadre et le PNNS 5 (et le PNA 4 si l'action concerne l'offre ou la restauration) comme programme.

2. Axes : « garantir à tous l'accès à des environnements nutritionnels durables favorables à la santé » ; « encourager des comportements nutritionnels sains et durables » ; « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé ».

3. Objectifs annoncés : réduire de 30 % la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (20 % chez ceux de familles défavorisées) ; 85 % d'enfants allaités à la naissance ; 40 % des Français utilisant le Nutri-Score ; 75 % du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score ; 12 % de consommation de produits bio.

4. Vérifier chaque chiffre dans le texte intégral officiel (site du ministère chargé de la santé, mangerbouger.fr) et non dans une synthèse secondaire ; citer la date.

Corrigé – Exercice 7.3

1. Taux de bio = 31 280 / 184 000 × 100 = 17,0 %. Produits durables et de qualité = 31 280 + 29 440 + 11 040 = 71 760 € ; taux = 71 760 / 184 000 × 100 = 39,0 %.

2. Bio : objectif d'au moins 20 %, non atteint ; montant à atteindre = 0,20 × 184 000 = 36 800 € ; il manque 36 800 − 31 280 = 5 520 €. Durables et de qualité : objectif d'au moins 50 %, non atteint ; montant à atteindre = 0,50 × 184 000 = 92 000 € ; il manque 92 000 − 71 760 = 20 240 €.

3. Leviers : diversification des protéines (plats de légumineuses moins chers) ; réduction du gaspillage (grammages adaptés, pesée des restes) ; achat de produits bio de saison ; marchés publics allotis pour permettre aux producteurs locaux de répondre ; travail avec le projet alimentaire territorial.

Corrigé – Exercice 7.4

1. Charcuterie : 300 g pour un repère de 150 g au plus, dépassement de 300 − 150 = 150 g (le double). Viande hors volaille : 700 g pour 500 g au plus, dépassement de 700 − 500 = 200 g. Légumes secs : jamais, pour au moins 2 fois par semaine. Fruits et légumes : 3 portions pour au moins 5. Boissons sucrées : 2 verres pour au plus 1 verre par jour. Pain blanc seulement : aller vers des féculents complets au moins une fois par jour. Poisson : une fois par mois pour 2 fois par semaine, dont 1 poisson gras. Huile de tournesol : aller vers les huiles de colza, de noix et d'olive. Produits laitiers : 2 par jour, conforme.

2. Exemples : « Remplacer 2 repas de viande par semaine par un plat de lentilles ou de pois chiches » ; « Ajouter un fruit au petit-déjeuner et des crudités au déjeuner » ; « Garder une boisson sucrée pour le week-end et boire de l'eau aromatisée en semaine ».

3. Le conseil individuel touche une personne et dépend de sa volonté ; ses effets sont limités si l'environnement ne change pas. L'entreprise peut améliorer l'offre de sa restauration (plats de légumineuses, poisson, pain complet, fruits), modifier les distributeurs, mettre des fontaines à eau, aménager les pauses : c'est créer un milieu favorable.

Corrigé – Exercice 7.5

1. Le Nutri-Score classe les aliments de A (meilleure qualité nutritionnelle) à E selon leur composition pour 100 g (éléments à limiter : énergie, sucres, acides gras saturés, sel ; éléments à favoriser : fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses). Il est facultatif (le droit européen ne permet pas de l'imposer). Il a été adopté par l'arrêté du 31 octobre 2017 ; le nouvel algorithme est rendu applicable par l'arrêté du 14 mars 2025, avec 2 ans de transition : meilleur classement des huiles riches en acides gras insaturés, des poissons gras et des céréales complètes, classement plus sévère des produits salés, sucrés et des boissons édulcorées.

2. Erreur 1 : le Nutri-Score ne mesure pas le degré de transformation (c'est la classification NOVA qui le fait) ; un produit noté A peut être ultra-transformé. Erreur 2 : il compare des produits d'une même catégorie et ne dit rien de la quantité

à consommer ; un aliment A ne se mange pas « autant qu'on veut ».

3. Utilisation : 40 − 33 = 7 points ; 7 / 33 × 100 = 21,2 % de hausse. Affichage : 75 − 62 = 13 points ; 13 / 62 × 100 = 21,0 % de hausse.

4. Exemple : jeu de classement de 6 paquets de céréales du petit-déjeuner par Nutri-Score, puis comparaison des listes d'ingrédients et des prix au kilo, et choix d'un petit-déjeuner complet.

Corrigé – Exercice 7.6

1. Loi EGalim (2018) : menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire, pérennisé par la loi Climat et résilience (2021) ; plan pluriannuel de diversification des protéines obligatoire au-delà de 200 couverts par jour (la cuisine centrale, avec 450 repas, est concernée).

2. Portion de viande : 0,070 × 12,00 = 0,84 €. Portion de lentilles : 0,060 × 3,60 = 0,216 €, soit 0,22 €. Économie par repas = 0,84 − 0,216 = 0,624 €, soit 0,62 €. Nombre de repas concernés par an : 450 × 36 = 16 200. Économie annuelle = 16 200 × 0,624 = 10 108,80 €.

3. Une seule santé : santé humaine (plus de fibres, apport de protéines végétales, moins d'acides gras saturés) ; santé des écosystèmes (moins d'émissions de gaz à effet de serre, légumineuses qui enrichissent le sol en azote) ; santé animale (moindre pression sur l'élevage intensif). SNANC : réduire l'impact de l'alimentation sur le climat, permettre l'accès à une alimentation plus saine, soutenir les agriculteurs (économie réinvestie dans le bio local).

4. Nutrition : équivalence protéique (associer légumineuses et céréales, compléter par un produit laitier ou un œuf), apport en fer (vitamine C dans le repas), grammages adaptés à l'âge. Acceptabilité : recettes testées avec les enfants, introduction progressive, présentation attractive, formation des cuisiniers aux cuissons des légumineuses, communication aux familles, suivi des restes pour mesurer l'acceptation.

Partie 8 – Le diététicien-nutritionniste en santé publique et la démarche de projet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer le cadre réglementaire de la profession (article L. 4371-1 du code de la santé publique) et ses missions en santé publique.
- Adopter une posture professionnelle éthique : non-stigmatisation, secret professionnel, RGPD, conflits d'intérêts.
- Décrire les étapes de la démarche de projet et rédiger des objectifs mesurables.
- Mobiliser toutes les notions du chapitre dans un cas complet.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Article L. 4371-1 du CSP : le diététicien dispense des conseils nutritionnels, participe sur prescription médicale à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients, contribue à la qualité de l'alimentation en collectivité et aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
- Le titre de diététicien est protégé (enregistrement au RPPS) ; le terme « nutritionniste » ne l'est pas.
- Démarche de projet : analyse et diagnostic, priorités et objectifs, plan d'action et moyens, communication, mise en œuvre, évaluation, valorisation et ajustements ; au centre : éthique, déontologie et participation.
- Besoins selon Bradshaw : normatif (défini par l'expert), ressenti (perçu par la personne), exprimé (ressenti devenu demande), comparatif (comparaison avec un groupe semblable).

Exercice 8.1 – Légender la démarche de projet (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

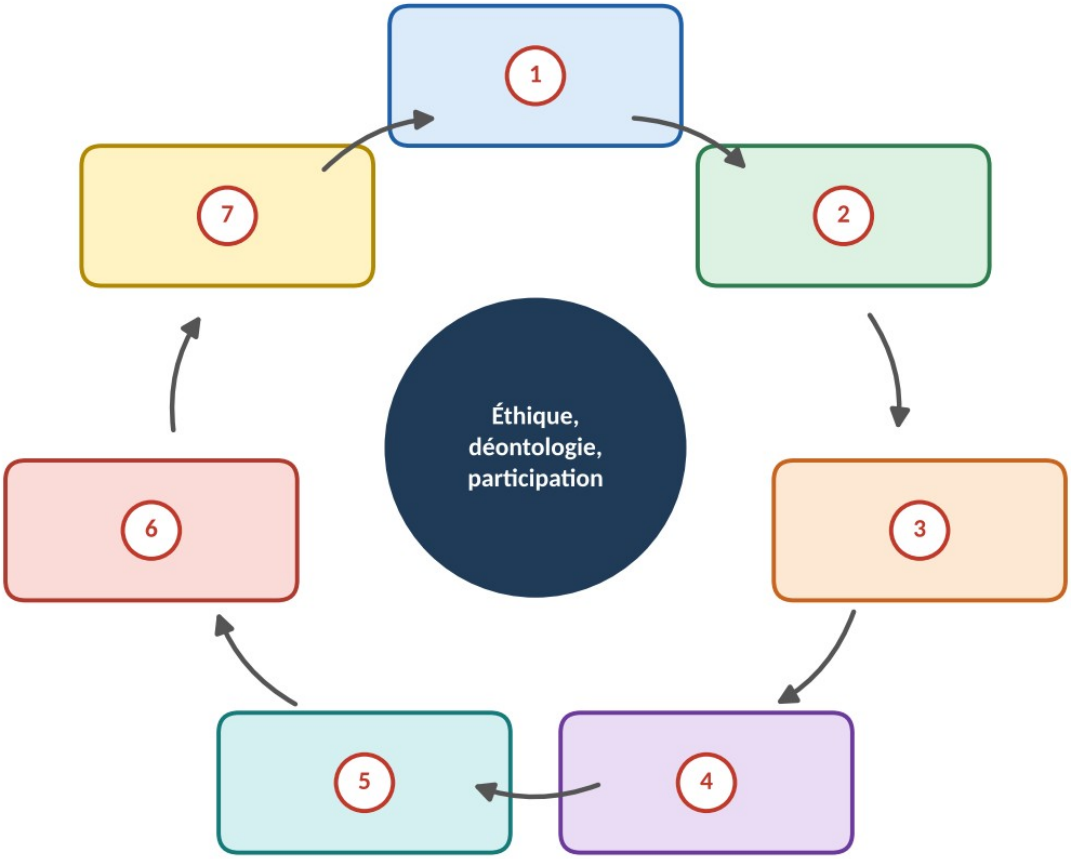


Figure 8.1 – Document 1 – La démarche de projet en santé publique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Associez à chaque étape un outil ou un document que vous produisez pendant le stage. (3,5 pts)

3. Expliquez pourquoi la démarche est représentée comme un cycle et ce que contient le disque central. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.2 – Le cadre réglementaire de la profession (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu vous demande pourquoi la commune devrait recruter une diététicienne plutôt qu'un « coach en nutrition » pour son projet de santé publique.

À vous de jouer – Questions

1. Citez les quatre champs d'exercice du diététicien définis par l'article L. 4371-1 du CSP. (4 pts)

2. Expliquez la différence entre « diététicien » et « nutritionniste » et le rôle du RPPS. (3 pts)

3. Citez trois employeurs possibles d'un diététicien en santé publique et une mission pour chacun. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 8.3 – Posture et déontologie en situation (12 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Document 1 – Six situations de stage

a) À la fin d'un atelier, une participante vous demande de lui écrire un régime pour son diabète.

b) Votre tutrice veut publier sur le site de la structure les photos de l'atelier, où l'on voit les visages des enfants.

c) Une marque de compotes propose de financer les ingrédients des ateliers en échange de son logo sur les affiches.

d) Une animatrice dit devant le groupe : « Avec ton poids, tu devrais éviter le fromage. »

e) Vous recevez par courriel la liste des familles inscrites avec leurs revenus et leurs problèmes de santé.

f) Un participant ne mange pas de porc et n'ose pas le dire.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, identifiez le principe éthique ou réglementaire en jeu et indiquez la conduite à tenir. (12 pts)

Ma réponse

Exercice 8.4 – Rédiger des objectifs mesurables (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – méthode · durée conseillée : 20 min*

Document 1 – Objectifs proposés par un stagiaire

a) « Faire prendre conscience aux familles de l'importance de bien manger. »

b) « Améliorer la santé des enfants. »

c) « Organiser des ateliers. »

d) « Que les gens mangent plus de légumes. »

e) « Diminuer l'obésité dans le quartier de 50 % en 3 mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez ce que signifie un objectif SMART. (2 pts)

2. Pour chaque objectif, indiquez son défaut et réécrivez-le de façon mesurable, en précisant s'il s'agit d'un objectif général, spécifique ou opérationnel. (10 pts)

Ma réponse

Exercice 8.5 – Classer les besoins selon Bradshaw (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous menez le diagnostic d'un projet dans une épicerie sociale (structure fictive). Vous avez noté les informations ci-dessous.

Document 1 – Informations recueillies

a) 12 bénéficiaires ont demandé à la responsable des recettes avec les produits de l'épicerie. b) Selon les repères de Santé publique France, il faut consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine ; seuls 3 bénéficiaires interrogés sur 20 le font. c) Plusieurs bénéficiaires disent se sentir fatigués et « mal manger », sans rien demander. d) L'épicerie sociale de la commune voisine propose des ateliers cuisine depuis 3 ans ; celle-ci n'en propose pas. e) Une bénévole pense que « les gens ne savent pas cuisiner ».

À vous de jouer – Questions

1. Définissez les quatre types de besoins de Bradshaw. (4 pts)

2. Classez les informations a à d. (4 pts)

3. Indiquez comment traiter l'information e dans le diagnostic. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 8.6 – Cas de synthèse : la santé alimentaire des étudiants d'un campus (30 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 30*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au service de santé étudiante d'une université (structure fictive) qui accueille 14 000 étudiants sur un campus en périphérie d'une ville moyenne. Le restaurant universitaire du CROUS est ouvert le midi en semaine. La direction du service vous confie un projet sur l'alimentation des étudiants, à mener avec l'association étudiante et le CROUS.

Document 1 – Enquête en ligne du service de santé étudiante (données fictives, mars 2026, 640 répondants)

Item	Nombre de « oui »
A sauté au moins un repas par manque d'argent au cours du dernier mois	243
Mange moins de 3 portions de fruits et légumes par jour	371
N'a pas de cuisine équipée dans son logement	154
Souhaite des ateliers « cuisine étudiante »	422

Document 2 – Moyens disponibles

Budget de 3 000 € sur l'année universitaire ; salle avec cuisine pédagogique à la maison des étudiants (8 postes) ; épicerie solidaire étudiante gérée par l'association ; réseaux sociaux de l'université et de l'association ; un diététicien du service à mi-temps.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les indicateurs de l'enquête et commentez la représentativité (taux de réponse, mode de recueil). (4 pts)

2. Qualifiez l'action (mode d'intervention, niveau de prévention, type selon Gordon) et classez les besoins selon Bradshaw. (4 pts)

3. Identifiez les déterminants en jeu en vous appuyant sur le modèle biopsychosocial. (3 pts)

4. Citez les acteurs et partenaires à mobiliser, du national au local, et la politique dans laquelle s'inscrit le projet. (4 pts)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels. (4 pts)

6. Proposez un plan d'action avec un budget détaillé qui respecte les 3 000 €. (4 pts)

7. Construisez l'évaluation et le plan de communication (précarité numérique, réseaux sociaux, e-réputation). (4 pts)

8. Indiquez trois points de vigilance éthique. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 8.1

1. Légendes : 1 Analyse et diagnostic de situation ; 2 Priorités et objectifs ; 3 Plan d'action et moyens ; 4 Plan de communication ; 5 Mise en œuvre ; 6 Évaluation ; 7 Valorisation et ajustements.

2. Exemples : diagnostic (fiche de diagnostic, arbre à problèmes) ; objectifs (arbre à objectifs, objectifs SMART) ; plan d'action (fiche projet, diagramme de Gantt, budget) ; communication (plan de communication, affiches) ; mise en œuvre (conducteur de séance, fiche technique, grille de dégustation) ; évaluation (questionnaire, tableau de bord) ; valorisation (bilan, tableau de veille, auto-évaluation).

3. L'évaluation produit des résultats qui alimentent un nouveau diagnostic et l'amélioration du projet : c'est un cycle. Au centre, l'éthique, la déontologie et la participation des personnes concernées s'appliquent à toutes les étapes.

Corrigé – Exercice 8.2

1. Dispenser des conseils nutritionnels ; participer, sur prescription médicale, à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients (bilan diététique, éducation diététique) ; contribuer à la qualité de l'alimentation servie en collectivité ; participer aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.

2. Le titre de diététicien est protégé : il est réservé aux titulaires des diplômes reconnus (BTS Diététique et nutrition, BUT Génie biologique parcours diététique et nutrition, ou autorisation d'exercice), enregistrés au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), ce qui permet de vérifier leur qualification. « Nutritionniste » n'est pas un titre protégé : n'importe qui peut l'utiliser. C'est une garantie de compétence et de respect des règles professionnelles pour la commune.

3. Exemples : commune ou CCAS (coordination du volet nutrition d'un contrat local de santé) ; conseil départemental (ateliers des 1000 premiers jours en PMI) ; mutuelle ou entreprise (programme de prévention pour les salariés).

Corrigé – Exercice 8.3

a) Limite de compétence et cadre de l'atelier : on ne prescrit pas de régime en atelier collectif ; on oriente vers le médecin traitant et une consultation diététique. b) Droit à l'image et RGPD : autorisation écrite des parents, possibilité de refuser, à défaut photos sans visage. c) Conflit d'intérêts : refuser la présence de la marque sur les supports ; chercher des financements publics ou des dons sans contrepartie publicitaire. d) Non-stigmatisation et respect : reprendre l'animatrice en privé, rappeler qu'on ne commente jamais le poids d'une personne en public. e) Confidentialité et minimisation des données : ces données sont excessives pour un atelier ; ne pas les diffuser, demander à les supprimer, conserver seulement ce qui est nécessaire. f) Respect des cultures et des choix : prévoir des alternatives dans les recettes et demander les habitudes alimentaires de façon discrète à l'inscription.

Corrigé – Exercice 8.4

1. SMART : spécifique, mesurable, atteignable (ambitieux mais réaliste), réaliste (pertinent au regard des moyens), temporellement défini.

2. a) Vague, non mesurable. Objectif spécifique : « D'ici 6 mois, 70 % des familles ayant participé à au moins 3 ateliers citent deux repères du PNNS et une recette qu'elles ont refaite. » b) Trop large : c'est un objectif général, à préciser : « Contribuer à améliorer l'alimentation des enfants de 3 à 6 ans des familles du centre social. » c) C'est une activité, pas un objectif : objectif opérationnel : « Animer 6 ateliers de 2 heures pour 10 familles entre janvier et juin. » d) Non mesurable, sans public ni échéance : « D'ici fin juin, faire passer de 25 % à 40 % la part des familles participantes qui servent des légumes au moins une fois par jour. » e) Irréaliste (durée trop courte, ampleur excessive, un projet local ne mesure pas la prévalence d'un quartier) : reformuler sur des comportements à court terme et laisser la prévalence à un objectif général de long terme.

Corrigé – Exercice 8.5

1. Normatif : défini par un expert à partir d'une norme. Ressenti : perçu par la personne, pas forcément exprimé. Exprimé : besoin ressenti transformé en demande. Comparatif : déduit de la comparaison avec un groupe semblable qui bénéficie d'un service.

2. a) Exprimé. b) Normatif (3 / 20 × 100 = 15,0 % suivent le repère). c) Ressenti. d) Comparatif.

3. C'est une représentation d'un professionnel ou d'un bénévole, pas un besoin du public : elle doit être vérifiée auprès des bénéficiaires (entretiens, questionnaire) et ne doit pas orienter seule le projet, au risque d'un jugement stigmatisant.

Corrigé – Exercice 8.6

1. Indicateurs (nombre / 640 × 100) : repas sautés par manque d'argent 243 / 640 = 38,0 % ; moins de 3 portions de fruits et légumes 371 / 640 = 58,0 % ; pas de cuisine équipée 154 / 640 = 24,1 % ; souhait d'ateliers 422 / 640 = 65,9 %. Taux de réponse = 640 / 14 000 × 100 = 4,6 % : très faible ; enquête en ligne avec réponses volontaires, donc les étudiants intéressés par le sujet ont pu répondre davantage et ceux sans connexion fiable moins. Les résultats sont une première indication, pas une mesure représentative.

2. Promotion de la santé (accès, milieux de vie) et éducation pour la santé (compétences culinaires) ; prévention primaire ; type sélectif pour les étudiants en précarité, universel pour l'offre ouverte à tous (universalisme proportionné). Besoins : normatif (moins de 3 portions de fruits et légumes pour un repère d'au moins 5) ; exprimé (65,9 % demandent des ateliers) ; ressenti (faim, fatigue, stress) ; comparatif (offre d'autres campus, données nationales de précarité étudiante).

3. Biologique : jeunes adultes, besoins énergétiques élevés. Psychologique : stress des examens, isolement, perte des repères familiaux. Social : budget limité, logement sans cuisine (24,1 %), campus en périphérie, horaires des cours, offre du restaurant universitaire limitée au midi en semaine.

4. National : ministère chargé de l'enseignement supérieur, CROUS (restauration et action sociale), PNNS 5 (axe 3 : « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé », dont l'enseignement supérieur) et SNANC. Régional : ARS (prévention, appels à projets). Local : université et service de santé étudiante, association étudiante et épicerie solidaire, CROUS local, commune, banques alimentaires. Le projet s'inscrit dans l'axe 3 du PNNS 5, qui mobilise les établissements d'enseignement supérieur comme promoteurs de santé.

5. Objectif général : contribuer à améliorer l'alimentation et à réduire l'insécurité alimentaire des étudiants du campus. Objectifs spécifiques : d'ici juin, 70 % des étudiants ayant suivi au moins 2 ateliers savent préparer 3 repas complets à moins de 2 € ; d'ici juin, 90 % des étudiants qui déclarent sauter des repas faute d'argent et qui consultent le service sont orientés vers l'épicerie solidaire ou une aide du CROUS. Objectifs opérationnels : animer 8 ateliers « cuisine étudiante » de 10 places ; organiser 2 marchés de produits frais à prix solidaire ; former 4 étudiants relais à l'orientation vers les aides.

6. Budget : 8 ateliers × 120 € = 960 € ; 2 marchés × 300 € (paniers de produits frais subventionnés) = 600 € ; communication 350 € ; formation des étudiants relais 2 × 400 € = 800 € ; évaluation 150 € ; total = 960 + 600 + 350 + 800 + 150 = 2 860 €, soit une réserve de 3 000 − 2 860 = 140 €.

7. Évaluation : processus (nombre d'ateliers et de participants, paniers distribués) ; résultats (compétences déclarées avant-après, orientations réalisées, repas sautés déclarés dans une nouvelle enquête) ; satisfaction. Communication : réseaux sociaux de l'association (canal principal des étudiants), affiches au restaurant universitaire et à la bibliothèque, relais des étudiants formés, information orale en amphithéâtre ; prise en compte de la précarité numérique (forfaits limités, absence d'ordinateur) par des supports papier et des inscriptions sur place ; e-réputation : pas de photo d'étudiant identifiable associée à la précarité, accord écrit, modération des commentaires.

8. Non-stigmatisation des étudiants en précarité (ateliers ouverts à tous) ; confidentialité des informations sociales et de santé (RGPD, accès limité au service) ; absence de lien commercial avec des marques ; participation des étudiants à la conception du projet.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir la santé (OMS, Ottawa, Huber) et distinguer les modèles de santé	1.1 à 1.6			
2	Définir la santé publique, ses missions ; calculer le paradoxe de Rose, une prévalence, une incidence	2.1 à 2.6			
3	Distinguer danger, exposition, risque, facteurs de risque et de protection ; calculer un risque ; hiérarchiser des problèmes	3.1 à 3.6			
4	Qualifier une action (mode, OMS, Gordon) ; utiliser la Charte d'Ottawa ; appliquer l'universalisme proportionné	4.1 à 4.6			
5	Situer les acteurs ; trouver une source de données ; construire un plan de financement ; repérer un conflit d'intérêts	5.1 à 5.6			
6	Expliquer SNS, PRS, CLS ; relier une action locale aux politiques ; répondre à un appel à projets	6.1 à 6.6			
7	Présenter PNNS 5, SNANC, PNA 4 ; calculer des taux EGalim ; utiliser les repères et le Nutri-Score	7.1 à 7.6			
8	Adopter une posture éthique ; rédiger des objectifs SMART ; classer les besoins ; traiter un cas complet	8.1 à 8.6			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.